Estilo UERJ

Simulado R03 Resolução

Gabarito, a armadilha de cada questão, o dado que decide e o raciocínio completo, alternativa por alternativa.

50 questões

26 de outubro de 2026

ANTES DE CORRIGIR

Como usar esta resolução

Corrija olhando primeiro a coluna da arma. O que interessa não é o total de acertos, é em qual armadilha você caiu.

ARMA DA BANCA	O QUE FAZ	QUESTÕES	ONDE ESTÃO
Rótulo verdadeiro	um dado real do paciente puxa para a doença de manual errada	21	2, 4, 9, 13, 17, 18, 21, 23, 26, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 43, 45, 46, 47, 48, 50
Negativo no meio	o discriminante é um dado negativo no meio do caso	5	1, 6, 22, 24, 40
Droga a deduzir	a droga em uso não é nomeada	2	29, 41
Grade X / Y	alternativa composta em que uma metade não basta	12	3, 5, 7, 10, 12, 14, 25, 27, 30, 33, 42, 44
Qualificador	o comando restringe o que se pede	2	37, 49
Limiar	um ponto de corte ou janela decide	3	8, 19, 28
Omissão	a resposta certa é não fazer, ou o degrau mais simples	1	32
Cronologia	o tempo entre os eventos decide	4	11, 15, 16, 20

O que cada arma treina em você

- **Rótulo verdadeiro, negativo no meio, dado omitido:** a leitura em modo confirmação, a sua maior causa de erro de identificação.
- **Grade X / Y e qualificador:** a alternativa aceita pela metade e o comando lido pela metade.
- **Limiar, cronologia e omissão:** a regra aplicada sem checar a condição que a habilita, e o exame ou tratamento a mais, o seu padrão dominante nos Simulados 1 a 4.
- **Droga a deduzir:** a droga em uso que decide e não vem nomeada.

Todas as questões têm uma única alternativa defensável pela diretriz citada. Se discordar de alguma, anote: discutir o gabarito é o melhor treino.

GABARITO

Respostas

1 **A**	2 **B**	3 **B**	4 **A**	5 **B**	6 **B**	7 **D**	8 **D**	9 **C**	10 **B**
11 **D**	12 **B**	13 **B**	14 **A**	15 **B**	16 **B**	17 **C**	18 **A**	19 **D**	20 **C**
21 **C**	22 **A**	23 **C**	24 **D**	25 **A**	26 **B**	27 **A**	28 **B**	29 **C**	30 **C**
31 **D**	32 **C**	33 **C**	34 **D**	35 **A**	36 **C**	37 **D**	38 **D**	39 **A**	40 **A**
41 **A**	42 **B**	43 **D**	44 **D**	45 **D**	46 **A**	47 **B**	48 **A**	49 **C**	50 **C**

A cor ao lado de cada letra é a da arma da banca, como na tabela anterior. Distribuição: A 13, B 13, C 12, D 12.

RESOLUÇÃO

Questão por questão

1

Hematologia · Plasmocitoma vertebral com medula abaixo de 10% e inventário radiográfico normal: estadiar com PET-CT ou RM antes de chamar de solitário

Negativo no meio

Gabarito A

Homem de 59 anos, hipertenso em uso de anlodipino, refere lombalgia mecânica há 3 meses, sem perda de peso e sem déficit neurológico. A RM da coluna toracolombar mostra lesão lítica única no corpo vertebral de T11, com componente de partes moles e sem compressão do canal. A biópsia guiada por TC revela infiltrado de plasmócitos monotípicos kappa. Hb 13,6 g/dL, cálcio 9,3 mg/dL, creatinina 0,9 mg/dL. Eletroforese de proteínas com pico de 0,5 g/dL, imunofixação IgG kappa, relação kappa/lambda das cadeias livres de 2,8. O inventário radiográfico do esqueleto (crânio, ossos longos, bacia e coluna) não mostra outras lesões. Aspirado e biópsia de crista ilíaca: plasmócitos clonais em 5% por citometria de fluxo. O radioterapeuta já agendou o planejamento. O próximo passo mais adequado é:

> O DADO QUE DECIDE
>
> *O inventário radiográfico do esqueleto (crânio, ossos longos, bacia e coluna) não mostra outras lesões*

Resolução. Lesão única com plasmócitos clonais na biópsia e medula com menos de 10% de plasmócitos clonais, sem anemia, hipercalcemia ou lesão renal, é plasmocitoma solitário com envolvimento medular mínimo, e a radioterapia local é o tratamento. A armadilha está no momento: o inventário radiográfico só detecta lesão lítica quando boa parte do osso trabecular já se perdeu e não é mais aceito para estadiar plasmocitoma. Cerca de um terço dos plasmocitomas aparentemente solitários tem outras lesões quando estudados por PET-CT ou RM de corpo inteiro (ou de coluna e pelve), e duas ou mais lesões transformam o caso em mieloma, com tratamento sistêmico. Por isso o IMWG exige imagem sensível antes de rotular como solitário. A cintilografia óssea depende de atividade osteoblástica, que o mieloma suprime, e subestima as lesões. A indução de mieloma seria precipitada com medula de 5% e lesão única ainda não confirmada.

A) PET-CT com FDG de corpo inteiro CORRETA

Correta. Antes de chamar a lesão de solitária, o estadiamento exige imagem sensível (PET-CT ou RM), porque o inventário radiográfico perde lesões e um terço desses casos já é mieloma.

B) Cintilografia óssea com tecnécio

Errada. A cintilografia detecta atividade osteoblástica, ausente nas lesões puramente líticas do mieloma, e por isso subestima a doença.

C) Indução com bortezomibe e transplante autólogo

Errada. Seria a conduta no mieloma múltiplo (plasmócitos clonais de 10% ou mais com evento definidor, ou duas lesões focais na RM); aqui a medula tem 5% e só há uma lesão conhecida.

D) Radioterapia local em dose curativa ARMADILHA

Errada. É a armadilha: seria a conduta depois de a PET-CT ou a RM confirmarem lesão única; tratar só T11 com outra lesão oculta deixa um mieloma sem tratamento sistêmico.

Para levar. Plasmocitoma solitário só se diagnostica depois de PET-CT ou RM sem outras lesões; o inventário radiográfico normal não basta, e medula abaixo de 10% não dispensa a imagem sensível.

Caers J et al. Diagnosis, treatment, and response assessment in solitary plasmacytoma: updated recommendations from the IMWG. Lancet Oncol 2018; Rajkumar SV. Multiple myeloma: 2024 update. Am J Hematol.

Revisa: S3 q11 (plasmocitoma com plasmócitos medulares abaixo de 10%): outro ângulo, o estadiamento por imagem sensível que precede a radioterapia

---

2

Cardiologia · Takotsubo com hipotensão por obstrução dinâmica da via de saída do VE: volume e betabloqueador, e não inotrópico

Rótulo verdadeiro **Gabarito B**

Mulher de 71 anos, hipertensa em uso de hidroclorotiazida, chega à emergência com dor torácica opressiva iniciada 1 hora após receber a notícia da morte do neto. ECG: supradesnivelamento do segmento ST de V2 a V5. A coronariografia de emergência mostrou placas de 30% na descendente anterior, sem lesão obstrutiva nem trombo, e a ventriculografia, acinesia dos segmentos médios e apicais com hipercinesia basal. Duas horas depois, na unidade coronariana: PA 78 × 50 mmHg, FC 114 bpm, extremidades frias, sonolenta, pulmões limpos à ausculta, sopro sistólico 3+/6 novo na borda esternal esquerda. Lactato 3,6 mmol/L, troponina I 2,4 ng/mL. Ecocardiograma à beira do leito: FE de 35%, gradiente intraventricular de 80 mmHg com movimento sistólico anterior da mitral, insuficiência mitral moderada e veia cava inferior de 12 mm com colapso inspiratório. A conduta mais adequada neste momento é:

O DADO QUE DECIDE

gradiente intraventricular de 80 mmHg com movimento sistólico anterior da mitral

Resolução. Hipotensão, extremidades frias, lactato alto e FE de 35% formam choque cardiogênico verdadeiro, e o reflexo é o inotrópico. Mas na síndrome de Takotsubo a base hipercinética pode criar obstrução dinâmica da via de saída do ventrículo esquerdo, com movimento sistólico anterior da mitral e insuficiência mitral, e esse é o mecanismo do choque desta paciente. Nesse caso a dobutamina aumenta a contratilidade basal e a frequência, agrava o gradiente e pode piorar o choque; nitratos e diuréticos reduzem a pré-carga e também pioram a obstrução. O tratamento é encher o ventrículo (volume, já que os pulmões estão limpos e a veia cava está colapsada) e reduzir a hipercinesia basal com betabloqueador de curta ação, como o esmolol, usando vasoconstritor puro (fenilefrina) se a pressão não responder, e suporte mecânico se refratário. O tiazídico em uso contribui para a hipovolemia relativa.

A) Angioplastia da descendente anterior
Errada. Seria a conduta no infarto anterior com oclusão da descendente; a coronariografia não mostrou lesão obstrutiva.

B) Expansão volêmica e betabloqueador de curta ação CORRETA
Correta. Volume e betabloqueador de curta ação reduzem a obstrução dinâmica da via de saída, que é a causa da hipotensão.

C) Nitroglicerina venosa e furosemida
Errada. Seria a conduta no Takotsubo com edema pulmonar e sem obstrução; aqui os pulmões estão limpos e a queda da pré-carga piora o gradiente.

D) Dobutamina em infusão contínua ARMADILHA

Errada. É a armadilha do choque cardiogênico; inotrópico aumenta a hipercinesia basal e o gradiente na obstrução dinâmica.

Para levar. No Takotsubo com hipotensão, procure obstrução dinâmica da via de saída no eco: se houver, evite inotrópico, nitrato e diurético, e use volume, betabloqueador de curta ação e, se preciso, fenilefrina.

Ghadri JR et al. International Expert Consensus Document on Takotsubo Syndrome (Part II): Diagnostic Workup, Outcome, and Management. Eur Heart J 2018; Lyon AR et al. Current state of knowledge on Takotsubo syndrome: a Position Statement from the HFA/ESC. Eur J Heart Fail 2016; 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes.

Revisa: UERJ recorrente: Takotsubo (agora a complicação hemodinâmica que inverte a conduta do choque)

3

Oncologia · Dispneia semanas após quimioterapia para tumor germinativo com corticoide antiemético e linfopenia: pneumonite por bleomicina pelo padrão subpleural basal, e não pneumocistose

Grade X / Y **Gabarito B**

Homem de 31 anos, tabagista de 10 maços-ano, foi submetido há 4 meses a orquiectomia por tumor de células germinativas não seminomatoso com metástases retroperitoneais e recebeu 3 ciclos de bleomicina, etoposídeo e cisplatina, o último há 6 semanas, com dexametasona como antiemético em todos os ciclos. Há 3 semanas tem tosse seca e dispneia progressiva, hoje aos pequenos esforços, sem febre. Exame: FR 24 irpm, FC 96 bpm, SatO2 93% em repouso e 85% ao caminhar, estertores finos em ambas as bases. Leucócitos 6.800/mm³ (linfócitos 1.100/mm³), DHL 410 U/L (referência até 250); alfafetoproteína e beta-hCG normalizados. DLCO de 41% do previsto (antes da quimioterapia: 88%). TC de tórax: reticulação e opacidades em vidro fosco subpleurais, predominando nas bases, com bandas parenquimatosas, sem nódulos, sem cistos e sem derrame. O diagnóstico e a conduta mais adequada são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

subpleurais, predominando nas bases

Resolução. Corticoide repetido nos ciclos, linfopenia, DHL alta, dispneia com dessaturação ao esforço e vidro fosco formam o retrato da pneumocistose, e é para lá que o apressado vai. A distribuição desmente: a pneumocistose dá vidro fosco difuso, central e peri-hilar, com frequência poupando a periferia, enquanto a toxicidade pulmonar da bleomicina dá reticulação e vidro fosco subpleurais, de predomínio basal, com bandas parenquimatosas, exatamente o descrito. A queda da DLCO de 88% para 41% é o marcador funcional mais sensível dessa toxicidade, e tabagismo e dose cumulativa aumentam o risco. Os marcadores normalizados e a ausência de nódulos afastam progressão tumoral. A conduta é não reexpor à bleomicina e iniciar prednisona em torno de 1 mg/kg com redução lenta, e esse paciente passa a ter restrição de oxigênio em fração alta e de volume em futuras anestesias, inclusive na linfadenectomia retroperitoneal.

A) Pneumocistose / sulfametoxazol-trimetoprima ARMADILHA

Errada. É a armadilha do corticoide e da DHL; seria o diagnóstico com vidro fosco difuso peri-hilar poupando a periferia, e não com reticulação subpleural basal e DLCO despencando depois da bleomicina.

B) Pneumonite por bleomicina / prednisona CORRETA

Correta. Reticulação e vidro fosco subpleurais basais, estertores em bases e DLCO em queda após bleomicina definem a pneumonite, tratada com corticoide e sem reexposição.

C) Metástases pulmonares / quimioterapia de resgate
Errada. Seria a resposta com nódulos pulmonares e marcadores em ascensão; aqui não há nódulos e alfafetoproteína e beta-hCG normalizaram.

D) Tromboembolismo pulmonar / anticoagulação
Errada. A cisplatina aumenta o risco de trombose, mas tromboembolismo não explica estertores, reticulação basal e queda progressiva da difusão.

Para levar. Dispneia com estertores em bases, reticulação subpleural basal e queda da DLCO após bleomicina é pneumonite pela droga: suspender para sempre, corticoide, e cuidado com oxigênio em fração alta em anestesias futuras.

NCCN Testicular Cancer (2025); Harrison's Principles of Internal Medicine, 21ª ed. (2022), cap. Testicular Cancer e Pulmonary Toxicity of Chemotherapy; ATS/ERS, revisão de pneumopatia induzida por drogas (2022).

Revisa: UERJ recorrente: toxicidade de quimioterápico a deduzir (bleomicina no tumor germinativo) + S4 q62 (toxicidade de terapia oncológica)

4

Neurologia · Tabagista rotulado como miastenia soronegativa, com boca seca e reflexos que surgem após contração: Lambert-Eaton e o incremento na ENMG

Rótulo verdadeiro

Gabarito A

Homem de 63 anos, tabagista de 50 maços-ano, encaminhado com diagnóstico de 'miastenia gravis soronegativa' por dificuldade para subir escadas e levantar-se da cadeira há 4 meses, com piora discreta no fim do dia e ptose leve bilateral. Refere boca seca intensa, constipação e disfunção erétil surgidas no mesmo período. Iniciou piridostigmina há 3 semanas, com melhora mínima. Anticorpos antirreceptor de acetilcolina e anti-MuSK negativos; CPK 140 U/L (referência até 190); TSH normal. Exame: força grau 4 menos em cinturas pélvica e escapular, musculatura ocular extrínseca livre, reflexos patelares e aquileus abolidos que surgem após 10 segundos de contração voluntária máxima do quadríceps, sensibilidade preservada. Radiografia de tórax: alargamento hilar direito. Na eletroneuromiografia, o achado esperado é:

O DADO QUE DECIDE

reflexos patelares e aquileus abolidos que surgem após 10 segundos de contração voluntária máxima do quadríceps

Resolução. O rótulo de miastenia soronegativa, a ptose e a piora no fim do dia levam ao padrão eletrofisiológico da miastenia. Três dados não cabem nela: fraqueza proximal de cinturas com ocular quase livre, disfunção autonômica colinérgica (boca seca, constipação, disfunção erétil) e reflexos abolidos que reaparecem após contração sustentada. Esse é o fenômeno de facilitação da síndrome de Lambert-Eaton, em que anticorpos contra canais de cálcio pré-sinápticos reduzem a liberação de acetilcolina, e o esforço acumula cálcio no terminal. Na ENMG, o potencial de ação muscular composto já é baixo em repouso e aumenta mais de 100% após 10 segundos de esforço ou com estimulação de alta frequência. No tabagista com alargamento hilar, a causa a buscar é carcinoma de pequenas células.

A) CMAP basal baixo, com incremento após esforço CORRETA
Correta. Defeito pré-sináptico: potencial basal baixo que aumenta mais de 100% após esforço, o mesmo fenômeno dos reflexos que reaparecem.

B) CMAP basal normal, com decremento a 3 Hz ARMADILHA

Errada. É o padrão da miastenia gravis pós-sináptica, com potencial basal normal; aqui a facilitação dos reflexos e a disautonomia apontam Lambert-Eaton.

C) Potenciais motores breves e polifásicos

Errada. Seria o achado de miopatia inflamatória, com CPK alta e reflexos preservados; a CPK é normal.

D) Condução lenta, com bloqueio de condução

Errada. Seria o padrão de polirradiculoneuropatia desmielinizante, com alteração sensitiva e sem facilitação após esforço.

Para levar. Fraqueza proximal com reflexos que reaparecem após contração e boca seca é Lambert-Eaton: potencial basal baixo com incremento após esforço, e busca de carcinoma de pequenas células.

Titulaer MJ et al. Lancet Neurol 2011 (Lambert-Eaton myasthenic syndrome: from clinical characteristics to therapeutic strategies); Harrison's Principles of Internal Medicine, 21ª ed. (2022), cap. Myasthenia Gravis and Other Diseases of the Neuromuscular Junction.

Revisa: S1 q24 (Lambert-Eaton): agora o rótulo de miastenia soronegativa e o padrão eletrofisiológico que separa pré de pós-sináptico

---

5

Endocrinologia · Cetoacidose tratada com 6 L de salina, cetonemia abaixo de 0,6 e ânion gap normal com bicarbonato baixo: acidose hiperclorêmica e transição para insulina subcutânea

Grade X / Y

Gabarito B

Homem de 24 anos, com diabetes tipo 1, foi admitido em cetoacidose após 2 dias sem insulina: glicemia 486 mg/dL, pH 7,08, bicarbonato 7 mEq/L, sódio 132 mEq/L, cloreto 96 mEq/L, beta-hidroxibutirato 6,2 mmol/L. Recebeu 6 L de solução salina a 0,9% nas primeiras 10 horas, insulina regular em infusão contínua e cloreto de potássio. Agora está lúcido, aceita dieta e não vomita. PA 124 × 78 mmHg, FC 88 bpm. Exames atuais: glicemia 212 mg/dL, pH venoso 7,31, bicarbonato 16 mEq/L, sódio 140 mEq/L, cloreto 116 mEq/L, potássio 4,0 mEq/L, beta-hidroxibutirato 0,4 mmol/L, lactato 1,1 mmol/L, creatinina 0,9 mg/dL. O residente propõe manter a insulina venosa até o bicarbonato passar de 18 mEq/L. O distúrbio que explica o bicarbonato baixo e a conduta mais adequada são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

beta-hidroxibutirato 0,4 mmol/L

Resolução. O bicarbonato de 16 mEq/L parece dizer que a cetoacidose não acabou, e a proposta do residente é manter a infusão até ele normalizar. O ânion gap atual é de 8 (140 menos 116 menos 16), e a cetonemia caiu para 0,4 mmol/L: os cetoânions foram metabolizados, e o que restou é acidose de ânion gap normal pelo cloreto da salina (6 L de solução com 154 mEq/L de cloreto) e pela perda urinária de cetoânions que seriam convertidos em bicarbonato. O consenso de crises hiperglicêmicas de 2024 define resolução pela cetonemia abaixo de 0,6 mmol/L com pH venoso de pelo menos 7,3, justamente para não prolongar a insulina venosa por causa da hipercloremia. Com o paciente comendo, a conduta é insulina basal subcutânea e manter a venosa por 1 a 2 horas de sobreposição; a hipercloremia se corrige sozinha, e soluções balanceadas evitam agravá-la se ainda for preciso volume.

A) Cetoacidose persistente / manter insulina venosa ARMADILHA

Errada. É a armadilha do bicarbonato: seria a conduta com cetonemia ainda alta e ânion gap aberto, mas aqui a cetonemia é de 0,4 mmol/L e o ânion gap é 8.

B) Hiperclorêmica / insulina subcutânea com sobreposição CORRETA

Correta. Cetonemia abaixo de 0,6 com pH de 7,31 define resolução; o bicarbonato baixo com ânion gap normal é hipercloremia, e o paciente que come passa para insulina subcutânea com sobreposição.

C) Acidose láctica / mais volume e antibiótico

Errada. Seria considerada com lactato alto e ânion gap aberto, como na sepse; o lactato de 1,1 mmol/L e o ânion gap de 8 a afastam.

D) Hiperclorêmica / bicarbonato e insulina venosa

Errada. Bicarbonato venoso não tem indicação na acidose hiperclorêmica leve com pH de 7,31, que se resolve com a função renal preservada.

Para levar. Na cetoacidose em tratamento, quem define a resolução é a cetonemia (abaixo de 0,6 mmol/L) com pH de pelo menos 7,3, e não o bicarbonato: bicarbonato baixo com ânion gap fechado após muita salina é hipercloremia.

Umpierrez GE et al. Hyperglycemic crises in adults with diabetes: a consensus report (ADA, EASD, JBDS, AACE, DTS). Diabetes Care 2024; ADA Standards of Care in Diabetes 2026, seção 16.

Revisa: UERJ recorrente: fluidos na cetoacidose e hipercloremia pela salina; ânion gap calculado no meio do caso

---

6

Reumatologia · Lúpica em indução com corticoide, de origem rural, com meningite e bacteremia por Gram-negativo e infiltrado pulmonar: hiperinfecção por Strongyloides, e não lúpus ativo

Negativo no meio | Gabarito B

Mulher de 29 anos, com nefrite lúpica classe IV diagnosticada há 6 semanas, recebeu pulsoterapia com metilprednisolona e está em prednisona 60 mg/dia e micofenolato 2 g/dia. Natural da zona rural do Vale do Jequitinhonha (MG), trabalhou descalça na lavoura até os 18 anos. Há 5 dias tem dor abdominal difusa, vômitos e diarreia; há 2 dias, tosse com escarro hemoptoico e dispneia; hoje febre de 39,2 °C, cefaleia e rigidez de nuca. PA 96 × 58 mmHg, FC 122 bpm, SpO2 de 89%. Leucócitos 18.400/mm³ com 0% de eosinófilos, Hb 9,8 g/dL, plaquetas 210.000/mm³, creatinina 1,1 mg/dL (era 2,0 no diagnóstico), C3 e C4 normais e anti-DNA que caiu de 1:640 para 1:40. TC de tórax com infiltrado alveolar bilateral. Líquor: 1.200 células/mm³, 90% de neutrófilos, Gram com bacilos Gram-negativos; hemoculturas com Escherichia coli. Além da antibioticoterapia, a conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

C3 e C4 normais e anti-DNA que caiu de 1:640 para 1:40

Resolução. Infiltrado alveolar bilateral com escarro hemoptoico em lúpica recém-induzida puxa para hemorragia alveolar e nova pulsoterapia. Mas o lúpus está em resposta: complemento normalizado, anti-DNA em queda e creatinina melhorando, o que tira a atividade lúpica do centro. A sequência sintomas gastrointestinais, infiltrado pulmonar com hemoptise, bacteremia e meningite por Gram-negativo entérico em quem recebe corticoide em dose alta e viveu descalça em área endêmica é a hiperinfecção por Strongyloides stercoralis: as larvas atravessam a parede intestinal levando bactérias da luz. A eosinopenia não afasta, porque o corticoide suprime os eosinófilos e a maioria das hiperinfecções cursa sem eosinofilia. O tratamento

é ivermectina (diária, até a negativação das pesquisas) com redução da imunossupressão o quanto possível, além do antibiótico para o Gram-negativo.

A) Pulsoterapia com metilprednisolona ARMADILHA
Errada. Seria a conduta na hemorragia alveolar lúpica, mas o complemento normal e o anti-DNA em queda mostram lúpus em resposta, e mais corticoide alimenta a hiperinfecção.

B) Ivermectina e redução do corticoide CORRETA
Correta. Hiperinfecção por Strongyloides com bacteremia e meningite por Gram-negativo entérico se trata com ivermectina e redução da imunossupressão.

C) Albendazol e manutenção do corticoide
Errada. O albendazol é inferior à ivermectina na estrongiloidíase, e manter corticoide em dose alta perpetua a autoinfecção.

D) Ciclofosfamida e plasmaférese
Errada. Seria indução de nefrite refratária ou de vasculite com hemorragia alveolar; aqui a nefrite melhora e o quadro é infeccioso.

Para levar. Lúpica em corticoide em dose alta com quadro gastrointestinal, pulmonar e bacteremia ou meningite por Gram-negativo entérico é hiperinfecção por Strongyloides até prova em contrário; eosinopenia não afasta, e o tratamento é ivermectina com redução da imunossupressão.

Mejia R, Nutman TB. Screening, prevention, and treatment for hyperinfection syndrome and disseminated infections caused by Strongyloides stercoralis, Curr Opin Infect Dis 2012; Henriquez-Camacho C et al. Ivermectin versus albendazole or thiabendazole for Strongyloides stercoralis infection, Cochrane 2016; Fanouriakis A et al. EULAR recommendations for the management of SLE, 2023 update.

Revisa: UERJ recorrente: LES como cenário de outra doença (estrongiloidíase no corticoide); padrão do aluno de atribuir tudo à atividade lúpica (S1 q11, S1 q61)

7

Infectologia · Leucoencefalopatia multifocal progressiva confirmada na aids sem TARV: iniciar a TARV logo, sem antiviral específico

Grade X / Y **Gabarito D**

Homem de 45 anos recebeu há 3 semanas o diagnóstico de HIV, com CD4 de 48 células/mm³ e carga viral de 380.000 cópias/mL, e ainda não iniciou TARV. Há 6 semanas evolui com perda de força progressiva no dimídio esquerdo, dificuldade para enxergar à esquerda e fala arrastada, sem febre, sem cefaleia e sem rebaixamento de consciência. Ao exame, hemiparesia esquerda grau 4, hemianopsia homônima esquerda e disartria, sem rigidez de nuca. A sorologia IgG para toxoplasmose é reagente; antígeno criptocócico sérico negativo; teste rápido molecular para tuberculose no escarro não detectado. RM de crânio: lesões hiperintensas em T2 e FLAIR na substância branca subcortical parieto-occipital direita, envolvendo as fibras em U, sem realce pelo gadolínio e sem efeito de massa. Líquor: 3 células/mm³, proteína 52 mg/dL, glicose normal, VDRL não reagente e PCR para vírus JC positiva. O residente lembra que, na meningite criptocócica, a TARV é adiada pelo risco de síndrome inflamatória de reconstituição imune. Quanto ao início da TARV e ao tratamento antiviral específico, respectivamente, a conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

PCR para vírus JC positiva

Resolução. A lembrança da meningite criptocócica é verdadeira e puxa para adiar a TARV, e a sorologia reagente para toxoplasma tenta abrir outro caminho. Mas a RM mostra lesões de substância branca subcortical com fibras em U, sem realce e sem efeito de massa, o oposto da neurotoxoplasmose, e a PCR para vírus JC no líquor confirma leucoencefalopatia multifocal progressiva. Não existe antiviral eficaz contra o JC: cidofovir, citarabina e mefloquina não mostraram benefício. O único tratamento que muda o prognóstico é recuperar a imunidade, e por isso a TARV deve começar o quanto antes, sem a espera usada na criptococose e na meningite tuberculosa. A síndrome inflamatória de reconstituição imune pode ocorrer, mas é tratada se aparecer (corticoide quando há edema e efeito de massa), e não justifica adiar.

A) Adiar por 4 a 6 semanas / cidofovir
Errada. Junta dois erros: o adiamento que vale para criptococose e meningite tuberculosa, e um antiviral sem eficácia contra o vírus JC.

B) Adiar por 4 a 6 semanas / nenhum ARMADILHA
Errada. É a armadilha da reconstituição imune: o adiamento serve às infecções meníngeas, em que a inflamação no espaço fechado mata; na LEMP, adiar deixa a doença avançar sem tratamento.

C) Iniciar em até 2 semanas / cidofovir
Errada. O momento está certo, mas cidofovir não tem benefício na LEMP e acrescenta nefrotoxicidade.

D) Iniciar em até 2 semanas / nenhum CORRETA
Correta. LEMP confirmada por PCR para JC: TARV precoce é o tratamento, e não há antiviral específico.

Para levar. Na LEMP não há antiviral: o tratamento é a TARV, iniciada sem demora. Adiar a TARV é exceção das infecções meníngeas (criptococo e tuberculose).

Ministério da Saúde, PCDT para Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos (2024); NIH/CDC/IDSA Guidelines for Prevention and Treatment of Opportunistic Infections in Adults with HIV, Progressive Multifocal Leukoencephalopathy (atualização 2024).

Revisa: S3 q71 e S1 q28: depois de confirmar LEMP, o momento da TARV é o inverso do da criptococose

---

8

Nefrologia · Hipomagnesemia em quem recebeu cisplatina e tem ileostomia de alto débito: fração de excreção de magnésio baixa aponta perda intestinal

Limiar **Gabarito D**

Homem de 52 anos, tratado de tumor de testículo com 4 ciclos de cisplatina há 3 anos e em remissão, foi submetido a colectomia total com ileostomia por retocolite ulcerativa há 8 meses. O débito da ileostomia está entre 1,8 e 2,2 litros por dia. Há 2 semanas tem câimbras e parestesias periorais. Usa mesalazina; nega diurético, inibidor de bomba de prótons e álcool. PA 112 × 70 mmHg, FC 96 bpm, sinal de Trousseau positivo. Exames: Na 136 mEq/L, K 3,1 mEq/L, cálcio total 7,6 mg/dL (albumina 4,0 g/dL), Mg 0,9 mg/dL (1,7 a 2,4), PTH 18 pg/mL (15 a 65), creatinina 1,0 mg/dL. Na urina de 24 horas, magnésio de 6 mg, com fração de excreção de magnésio calculada em 0,8%. A causa mais provável da hipomagnesemia é:

O DADO QUE DECIDE

fração de excreção de magnésio calculada em 0,8%

Resolução. A cisplatina causa perda tubular de magnésio que pode persistir por anos, e a exposição é verdadeira, o que puxa para a tubulopatia. O que separa perda renal de perda extrarrenal é a resposta do rim: diante de hipomagnesemia, a fração de excreção de magnésio acima de 2 a 4% (ou mais de 10 a 30 mg na urina de 24 horas) indica perda renal, e abaixo de 2% indica rim conservando adequadamente, com a perda

fora dele. Aqui a fração é de 0,8% e o magnésio urinário de 24 horas é de 6 mg, ou seja, o túbulo está poupando magnésio ao máximo. A fonte é a ileostomia de alto débito, que perde magnésio e também potássio. O PTH inapropriadamente normal com hipocalcemia é consequência da hipomagnesemia grave, que inibe a secreção e a ação do PTH, e corrige com a reposição de magnésio.

A) Síndrome de Gitelman de expressão tardia
Errada. Gitelman cursa com alcalose, hipocalciúria e perda renal de magnésio; a fração de excreção baixa exclui perda tubular.

B) Toxicidade tubular pela mesalazina
Errada. A mesalazina causa nefrite intersticial com queda de função, e não perda isolada de magnésio; a creatinina é normal e o rim está conservando magnésio.

C) Tubulopatia residual pela cisplatina ARMADILHA
Errada. É a armadilha da exposição: a tubulopatia pela cisplatina daria fração de excreção de magnésio alta, e não 0,8%.

D) Perda intestinal pela ileostomia de alto débito CORRETA
Correta. Fração de excreção de magnésio abaixo de 2% com débito de ileostomia de 2 litros por dia indica perda gastrointestinal.

Para levar. Na hipomagnesemia, meça o magnésio urinário: fração de excreção abaixo de 2% é perda extrarrenal (intestino), acima de 2 a 4% é perda renal (cisplatina, aminoglicosídeo, diurético, Gitelman).

Agus ZS. Mechanisms and causes of hypomagnesemia. Curr Opin Nephrol Hypertens 2016; Brenner and Rector's The Kidney, 11ª ed. (2020), cap. Disorders of Magnesium Balance.

Revisa: UERJ recorrente: hipomagnesemia; usar a urina para localizar a perda, e não a exposição mais chamativa

---

9

Hematologia · Eritrocitose adquirida com eritropoetina alta, sem hipoxemia e anterior ao iSGLT2: procurar tumor secretor de EPO, e não o éxon 12 do JAK2

Rótulo verdadeiro **Gabarito C**

Homem de 61 anos, diabético, ex-tabagista (parou há 8 anos), encaminhado por eritrocitose. Usa metformina e, há 4 meses, empagliflozina; não usa testosterona. Hemograma de 2 anos atrás: hematócrito de 43%. Assintomático, sem prurido aquagênico, sem eritromelalgia, sem roncos ou sonolência diurna. Exame: PA 138 x 84 mmHg, pletora facial discreta, baço e fígado não palpáveis, sem massas abdominais. Exames: Hb 19,1 g/dL, hematócrito 57%, leucócitos 7.200/mm³, plaquetas 248.000/mm³, eritropoetina sérica 54 mUI/mL (referência: 4 a 26), JAK2 V617F negativo, SpO2 96% em ar ambiente e carboxi-hemoglobina 1,1%. Ao revisar o prontuário, o residente encontra hematócrito de 52% num exame de rotina colhido um mês antes de iniciar a empagliflozina. Creatinina 0,9 mg/dL, urina tipo 1 sem hematúria. A conduta mais adequada agora é:

> O DADO QUE DECIDE
> *hematócrito de 52% num exame de rotina colhido um mês antes de iniciar a empagliflozina*

Resolução. Os inibidores de SGLT2 elevam de fato o hematócrito e a eritropoetina, e a droga recente é o rótulo verdadeiro que convida a suspender e esperar. Mas o efeito do iSGLT2 é de poucos pontos de hematócrito, e o exame anterior à droga já mostrava 52%, de modo que a eritrocitose começou antes dela. A eritropoetina alta separa os caminhos: na policitemia vera, inclusive na do éxon 12, a EPO está baixa ou

suprimida, o que torna o éxon 12 inútil aqui. EPO alta exige procurar hipóxia (afastada: saturação normal, carboxi-hemoglobina normal, sem sintomas de apneia) ou produção inapropriada de EPO, e a de surgimento recente num homem de 61 anos aponta tumor: carcinoma de células renais, hepatocarcinoma, hemangioblastoma, leiomioma uterino ou feocromocitoma. A imagem abdominal com contraste é o passo. Hemoglobina de alta afinidade é congênita, com eritrocitose desde a juventude, e o hematócrito de 43% há 2 anos a afasta.

A) Pesquisar mutação no éxon 12 do JAK2
Errada. O éxon 12 se pesquisa na suspeita de policitemia vera com V617F negativo, mas essa doença cursa com eritropoetina baixa, e aqui ela está alta.

B) Medir a P50 da hemoglobina
Errada. A P50 baixa identifica hemoglobina de alta afinidade, causa congênita com eritrocitose desde cedo; o hematócrito normal há 2 anos a afasta.

C) Tomografia de abdome com contraste CORRETA
Correta. Eritrocitose adquirida com eritropoetina alta e sem hipóxia é produção inapropriada de EPO até prova em contrário, e rim e fígado são os sítios a estudar primeiro.

D) Suspender a empagliflozina e repetir em 3 meses ARMADILHA
Errada. É a armadilha do rótulo verdadeiro: o iSGLT2 eleva pouco o hematócrito, e a eritrocitose já existia antes de ele ser iniciado.

Para levar. Eritrocitose com EPO alta e saturação normal, de surgimento recente, pede imagem abdominal atrás de tumor secretor de EPO; EPO alta afasta policitemia vera, inclusive a do éxon 12.

McMullin MF et al. A guideline for the diagnosis and management of polycythaemia vera. A British Society for Haematology guideline. Br J Haematol 2019; Gangat N et al. Secondary polycythemia. Am J Hematol 2021.

Revisa: UERJ recorrente: policitemia vera x eritrocitose secundária pela eritropoetina, com o iSGLT2 como rótulo verdadeiro

---

10 Gastroenterologia e hepatologia · HBsAg reagente com HBV-DNA indetectável, ALT alta e hipertensão portal em paciente da Amazônia: supressão pelo vírus delta e anti-HDV

Grade X / Y **Gabarito B**

Homem de 38 anos, natural de Lábrea (AM), mora no Rio de Janeiro há 2 anos e é encaminhado por plaquetopenia achada em exame admissional. Sabe ter HBsAg reagente há 10 anos e foi rotulado em outro serviço como portador inativo, sem tratamento. Bebe duas latas de cerveja por semana, nega drogas injetáveis e transfusões; IMC de 24 kg/m², sem diabetes. Ao exame, PA 118/74 mmHg, aranhas vasculares no tórax e baço palpável a 3 cm do rebordo costal, sem ascite. Exames: ALT 96 U/L e AST 88 U/L (referência até 41), plaquetas 98.000/mm³, albumina 3,6 g/dL, INR 1,2, bilirrubina total 1,1 mg/dL. HBeAg não reagente, anti-HBe reagente, HBV-DNA indetectável (limite de detecção de 10 UI/mL), anti-HCV e anti-HIV não reagentes, ferritina 240 ng/mL. Elastografia hepática transitória: 14,8 kPa. Ultrassonografia: fígado de contornos irregulares, sem nódulos, veia porta pérvia. A interpretação do HBV-DNA indetectável e o próximo exame mais adequado são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE
natural de Lábrea (AM)

Resolução. HBeAg negativo, anti-HBe reagente e HBV-DNA indetectável são verdadeiros e montam o perfil do portador inativo, rótulo que o paciente já traz; a tentação é só repetir a carga viral. Mas portador inativo tem ALT normal e fígado sem doença, e aqui há ALT duas vezes o limite, plaquetopenia, esplenomegalia, aranhas vasculares e elastografia de 14,8 kPa, ou seja, doença hepática avançada em atividade sem replicação do HBV que a explique. Lábrea, no sul do Amazonas, é área hiperendêmica de hepatite delta, e o HDV, que depende do HBsAg, suprime a replicação do HBV enquanto produz a hepatite mais agressiva das hepatites virais. Por isso o HBV-DNA indetectável, longe de tranquilizar, reforça a suspeita, e o exame seguinte é o anti-HDV total, com HDV-RNA se reagente. O mutante pré-core cursa com carga viral detectável, muitas vezes alta, e não indetectável.

A) Infecção crônica inativa / HBV-DNA em 6 meses ARMADILHA
Errada. Seria a leitura certa com ALT normal e fígado sem fibrose; ALT elevada, plaquetopenia e esplenomegalia afastam a fase inativa.

B) Supressão pelo vírus delta / anti-HDV total CORRETA
Correta. Paciente de área hiperendêmica, com doença hepática ativa e avançada e HBV-DNA suprimido: pesquisar coinfecção pelo HDV com anti-HDV total.

C) Mutante pré-core / sequenciamento do HBV
Errada. O mutante pré-core explica HBeAg negativo com hepatite ativa, mas sempre com HBV-DNA detectável, geralmente acima de 2.000 UI/mL.

D) Hepatopatia não viral / FAN e IgG séricos
Errada. Hepatite autoimune ou outra causa entraria após afastar o delta; num portador de HBsAg da Amazônia, o HDV vem antes.

Para levar. HBsAg reagente com HBV-DNA baixo ou indetectável e doença hepática ativa ou avançada pede anti-HDV, sobretudo em quem veio da Amazônia Ocidental: o HDV suprime o HBV e acelera a cirrose.

EASL Clinical Practice Guidelines on hepatitis delta virus, 2023; Ministério da Saúde, PCDT Hepatite B e Coinfecções, 2023.

Revisa: UERJ recorrente: hepatite B com HBV-DNA indetectável usado como distrator da fase da infecção

---

11

Endocrinologia · Hiponatremia no oitavo dia após cirurgia hipofisária em paciente que saiu de alta com desmopressina: segunda fase da resposta trifásica, suspender a droga e restringir água

Cronologia **Gabarito D**

Mulher de 44 anos foi submetida a ressecção transesfenoidal de macroadenoma não funcionante de 2,8 cm. Nas primeiras 48 horas, teve diurese de 5,5 L/dia, osmolalidade urinária de 110 mOsm/kg e sódio de 147 mEq/L, e passou a receber desmopressina 0,1 mg via oral de 12 em 12 horas, mantida na prescrição de alta no 4º dia, com sódio de 140 mEq/L. Cortisol sérico às 8 horas no 3º dia: 17 µg/dL, sem glicocorticoide desde a cirurgia. No 8º dia, comparece ao retorno ambulatorial assintomática; bebe cerca de 3 L de água por dia, por orientação de manter-se hidratada. PA 118 × 74 mmHg, sem edema ou sinais de desidratação. Sódio 126 mEq/L, potássio 4,1 mEq/L, osmolalidade plasmática 262 mOsm/kg, osmolalidade urinária 540 mOsm/kg, sódio urinário 68 mEq/L, glicemia e TSH normais. A conduta mais adequada neste momento é:

O DADO QUE DECIDE

No 8º dia, comparece ao retorno ambulatorial assintomática

Resolução. Hiponatremia após cirurgia hipofisária faz pensar logo em insuficiência adrenal secundária, mas o cortisol de 17 µg/dL sem glicocorticoide exógeno afasta essa hipótese, e o TSH normal afasta hipotireoidismo. A cronologia é a da resposta trifásica: diabetes insípido nos primeiros dias pela lesão da haste, seguido entre o 5º e o 10º dia pela liberação descontrolada do ADH armazenado nos terminais neuro-hipofisários degenerados, que produz um quadro de secreção inapropriada. Nessa fase, a desmopressina que tratava o diabetes insípido soma antidiurese à antidiurese, e os 3 L de água ofertados completam a hiponatremia. A paciente está assintomática, então não há indicação de salina hipertônica: suspende-se a desmopressina, restringe-se a água e o sódio é acompanhado de perto, porque a fase seguinte pode ser diabetes insípido permanente.

A) Manter a desmopressina e associar tolvaptana

Errada. Manter a desmopressina perpetua a antidiurese; tolvaptana ficaria para secreção inapropriada persistente que falha à restrição, nunca associada a um agonista do mesmo receptor.

B) Solução salina a 3% em bolus

Errada. Seria a conduta na hiponatremia com sintomas graves ou moderadamente graves; esta paciente está assintomática.

C) Hidrocortisona em dose de estresse ARMADILHA

Errada. É a armadilha do pós-operatório hipofisário: seria a conduta na insuficiência adrenal secundária, mas o cortisol de 17 µg/dL sem glicocorticoide a afasta.

D) Suspender a desmopressina e restringir água CORRETA

Correta. No 8º dia, a fase de secreção inapropriada somada à desmopressina e à água explica o quadro, e retirar a droga com restrição hídrica resolve sem risco.

Para levar. Após cirurgia hipofisária, diabetes insípido nos primeiros dias pode virar secreção inapropriada entre o 5º e o 10º dia: desmopressina prescrita na alta precisa ser revista nesse intervalo, com sódio de controle.

Spasovski G et al. Clinical practice guideline on diagnosis and treatment of hyponatraemia. Eur J Endocrinol 2014; Fleseriu M et al. Hormonal replacement in hypopituitarism in adults: Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab 2016.

Revisa: S4 q50 (marcou polidipsia primária na hiponatremia do 8º dia): agora com a desmopressina de alta como agravante e o cortisol normal no meio

---

12 Cardiologia · Insuficiência mitral crônica grave por prolapso do folheto posterior: sopro irradiado para a base, B3 e desdobramento amplo de B2, e não a ausculta da estenose aórtica

Grade X / Y **Gabarito B**

Homem de 61 anos, hipertenso controlado com losartana, sem antecedente de febre reumática, procura atendimento por dispneia aos esforços moderados que piorou nos últimos 8 meses. Ecocardiograma feito há 4 anos, em exame admissional, descreveu prolapso do folheto posterior da valva mitral com refluxo discreto; não voltou ao cardiologista. Nega angina e síncope. Ao exame: PA 134 × 78 mmHg, FC 76 bpm, rítmico; pulso carotídeo de ascensão rápida e amplitude normal; ictus no 6º espaço intercostal, na linha axilar anterior, propulsivo, com duas polpas digitais. Sopro sistólico 4+/6, que começa junto com a B1 e se mantém em platô até a B2, mais audível na borda esternal esquerda alta e no foco aórtico, com irradiação para as carótidas; B1 hipofonética. ECG: ritmo sinusal, sem sobrecarga ventricular esquerda com strain. Além do sopro descrito, espera-se encontrar na ausculta, quanto à bulha extra e ao comportamento da B2, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

pulso carotídeo de ascensão rápida e amplitude normal

Resolução. O sopro sistólico intenso no foco aórtico irradiado para as carótidas, num homem de 61 anos hipertenso, puxa para estenose aórtica calcificada grave, cuja ausculta tem quarta bulha e B2 única pelo desaparecimento do componente aórtico. Mas a estenose aórtica grave daria pulso de ascensão lenta e amplitude reduzida, e aqui o pulso carotídeo sobe rápido; o sopro é holossistólico em platô, começa junto com a B1 e a B1 é hipofonética, o que aponta para regurgitação mitral. O ecocardiograma antigo dá a chave da irradiação: no prolapso ou ruptura de cordoalha do folheto posterior o jato é excêntrico e dirigido para a frente, contra o septo interatrial junto à raiz da aorta, e o sopro se propaga para a base e as carótidas, imitando estenose aórtica. Na insuficiência mitral crônica grave, o grande volume que volta do átrio esquerdo na diástole produz terceira bulha mesmo sem disfunção sistólica, e o esvaziamento precoce do ventrículo esquerdo antecipa o componente aórtico, alargando o desdobramento da B2. O ictus desviado e propulsivo confirma a sobrecarga de volume.

A) Quarta bulha / B2 única ARMADILHA

Errada. É a ausculta da estenose aórtica calcificada grave, que a irradiação para as carótidas sugere; o pulso de ascensão rápida e a B1 hipofonética derrubam essa hipótese.

B) Terceira bulha / desdobramento amplo de B2 CORRETA

Correta. Insuficiência mitral crônica grave tem B3 por hiperfluxo diastólico e desdobramento amplo de B2 pelo fechamento aórtico precoce.

C) Quarta bulha / desdobramento paradoxal de B2

Errada. Desdobramento paradoxal aparece com bloqueio de ramo esquerdo ou estenose aórtica grave com ventrículo hipertrófico; o ECG não mostra bloqueio nem sobrecarga com strain.

D) Estalido de abertura / B1 hiperfonética

Errada. Estalido de abertura e B1 hiperfonética são da estenose mitral reumática; aqui a B1 é hipofonética e não há história reumática.

Para levar. Na insuficiência mitral por prolapso ou ruptura do folheto posterior, o jato vai para a frente e o sopro irradia para a base e as carótidas; pulso de ascensão rápida, B1 hipofonética, B3 e desdobramento amplo de B2 separam da estenose aórtica.

2020 ACC/AHA Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease; 2025 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease; Braunwald's Heart Disease, 12ª ed. (2022), cap. Physical Examination of the Heart and Circulation.

Revisa: UERJ recorrente: IM crônica grave e sua ausculta + S3 q5 e S4 q65 (achado esperado, 0 de 8)

---

13 Pneumologia · Silicose com lesão nova captante no PET-CT e linfonodos mediastinais captantes: escarro para tuberculose antes de estadiar como câncer

Rótulo verdadeiro **Gabarito B**

Homem de 52 anos, jateador de areia em estaleiro por 22 anos, com silicose diagnosticada há 6 anos (nódulos centrolobulares e conglomerados nos lobos superiores), tabagista de 30 maços-ano, procura atendimento por tosse produtiva há 2 meses, perda de 5 kg e febre baixa vespertina. Nega hemoptise. Ao exame, FR 20 irpm, SpO2 94% em ar ambiente, emagrecido, sem linfonodos periféricos palpáveis. A TC comparada com a de 1 ano atrás mostra aumento de um conglomerado no lobo superior direito, que agora tem área de escavação central.

O médico que o acompanha solicitou PET-CT, cujo laudo descreve "lesão hipermetabólica no lobo superior direito (SUVmax 9,4) e linfonodos mediastinais e hilares hipermetabólicos (SUVmax 6,1), achados suspeitos de neoplasia". Escarra com facilidade pela manhã, mas nenhuma amostra de escarro foi colhida até agora. Hemograma com leucócitos de 9.800/mm³ e PCR de 46 mg/L. O próximo exame mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

nenhuma amostra de escarro foi colhida até agora

Resolução. O laudo do PET-CT e o tabagismo são verdadeiros e puxam para câncer de pulmão já com linfonodos mediastinais, o que levaria à ecobroncoscopia para estadiar. Mas a captação de FDG não distingue neoplasia de inflamação granulomatosa: tuberculose ativa capta intensamente, e os conglomerados e linfonodos silicóticos também captam. O silicótico tem risco muito aumentado de tuberculose, e escavação nova num conglomerado, com febre vespertina e emagrecimento, é tuberculose até prova em contrário. Como ele escarra, o passo seguinte é o mais barato e o que muda tudo: teste rápido molecular e cultura no escarro (com teste de sensibilidade). Só se a investigação para tuberculose for negativa é que se parte para a amostragem invasiva da lesão ou dos linfonodos.

A) Ecobroncoscopia com punção linfonodal ARMADILHA
Errada. É a armadilha do PET: a ecobroncoscopia estadiaria o mediastino num câncer de pulmão provável; aqui os linfonodos captantes cabem na silicose e na tuberculose, e o escarro ainda não foi examinado.

B) Teste rápido molecular e cultura no escarro CORRETA
Correta. Silicose com escavação nova, febre e emagrecimento num paciente que escarra: teste rápido molecular e cultura antes de qualquer exame invasivo.

C) Biópsia transtorácica guiada por TC
Errada. Seria o caminho num nódulo suspeito periférico sem suspeita infecciosa; aqui expõe a punção a um conglomerado escavado antes de afastar tuberculose pelo escarro.

D) Lobectomia superior direita diagnóstica
Errada. A ressecção sem diagnóstico se reserva ao nódulo de alta probabilidade de câncer sem alternativa plausível; na silicose com cavidade nova, a tuberculose é a hipótese a afastar primeiro.

Para levar. No silicótico, lesão nova ou escavada é tuberculose até prova em contrário, mesmo com PET captante: teste rápido molecular e cultura no escarro antes de broncoscopia, biópsia ou estadiamento.

Ministério da Saúde. Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil, 2ª ed. atualizada (2019); Diretrizes SBPT para pneumoconioses; ACCP Lung Cancer Guidelines (2013).

Revisa: S4 q27: na silicose, tuberculose antes de câncer; o PET captante como novo rótulo verdadeiro que puxa para o estadiamento invasivo

---

14 Reumatologia · Microangiopatia trombótica na esclerose sistêmica difusa precoce após prednisona: crise renal com ADAMTS13 só discretamente baixa, captopril e não plasmaférese

Grade X / Y Gabarito A

Mulher de 41 anos, com esclerose sistêmica cutânea difusa diagnosticada há 8 meses, escore de Rodnan de 28 e anti-RNA polimerase III reagente, iniciou há 4 semanas prednisona 40 mg/dia por miosite sobreposta. Há 3 dias tem cefaleia e visão turva. PA 186 × 112 mmHg (habitual de 100 × 60), FC 96 bpm, sem febre, sem alteração

do nível de consciência. Hb 8,1 g/dL, plaquetas 72.000/mm³, esquizócitos em 3% das hemácias, LDH 980 U/L, haptoglobina indetectável, Coombs direto negativo. Creatinina 2,4 mg/dL (0,7 há 1 mês), proteinúria 1+ e hematúria discreta. Atividade da ADAMTS13 de 48% (referência: 60 a 130%). Fundo de olho com hemorragias em chama de vela e exsudatos algodonosos. O diagnóstico e o tratamento mais adequados são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

Atividade da ADAMTS13 de 48% (referência: 60 a 130%)

Resolução. Esquizócitos, plaquetopenia, LDH alta e haptoglobina indetectável compõem uma microangiopatia trombótica, e a ADAMTS13 abaixo da referência parece confirmar púrpura trombocitopênica trombótica. Mas a PTT adquirida exige atividade grave, abaixo de 10%; valores de 40 a 60% aparecem em várias microangiopatias secundárias e não definem a doença. O cenário é de crise renal esclerodérmica: doença difusa precoce, anti-RNA polimerase III, corticoide acima de 15 mg/dia, hipertensão acelerada com retinopatia e creatinina que triplicou em um mês. O tratamento é inibidor da ECA de ação curta (captopril) em doses crescentes até controlar a pressão, mantido mesmo se a creatinina subir, com redução do corticoide ao menor possível. A plasmaférese não tem papel definido na crise renal e atrasa a medida que muda o prognóstico.

A) Crise renal esclerodérmica / captopril em doses crescentes CORRETA
Correta. Esclerose sistêmica difusa precoce, anti-RNA polimerase III, corticoide em dose moderada, hipertensão acelerada e microangiopatia com ADAMTS13 só discretamente baixa são crise renal, tratada com captopril escalonado.

B) Púrpura trombocitopênica trombótica / plasmaférese ARMADILHA
Errada. Seria a conduta na PTT adquirida, que exige ADAMTS13 abaixo de 10%; o valor de 48% não sustenta o diagnóstico.

C) Crise renal esclerodérmica / plasmaférese
Errada. O diagnóstico está certo, mas a plasmaférese não é o tratamento da crise renal; o que muda o desfecho é o inibidor da ECA.

D) Púrpura trombocitopênica trombótica / captopril em doses crescentes
Errada. Combina um diagnóstico sem respaldo laboratorial com um tratamento que não corrige a deficiência de ADAMTS13 se ela fosse grave.

Para levar. Microangiopatia trombótica com hipertensão acelerada na esclerose sistêmica difusa precoce, sobretudo com anti-RNA polimerase III e corticoide acima de 15 mg/dia, é crise renal: captopril escalonado. PTT exige ADAMTS13 abaixo de 10%.

Kowal-Bielecka O et al. Update of EULAR recommendations for the treatment of systemic sclerosis, 2017; Zheng XL et al. ISTH guidelines for the diagnosis of thrombotic thrombocytopenic purpura, 2020; Bose N et al. Scleroderma renal crisis, Semin Arthritis Rheum 2015.

Revisa: S1 q91 e S1 q51: crise renal esclerodérmica contra PTT, com o limiar da ADAMTS13 como rótulo verdadeiro

15 Neurologia · Encefalite temporal com PCR para herpes negativa no líquor das primeiras 24 horas: manter aciclovir e repetir a PCR

Cronologia **Gabarito B**

Mulher de 54 anos, previamente hígida, é trazida pelo marido com 3 dias de febre de 38,6 °C e cefaleia e, desde o dia anterior, comportamento estranho, queixa de 'cheiro de queimado' e uma crise focal com automatismos orais. Nega viagens, contato com animais e vacinação recente. Glasgow 14, desorientada, rigidez de nuca discreta, sem déficit motor. RM: hipersinal em FLAIR e restrição à difusão no lobo temporal medial e na ínsula à esquerda. Líquor, colhido nas primeiras 24 horas dos sintomas neurológicos: 18 células/mm³ (90% linfócitos), 6 hemácias/mm³, proteína 62 mg/dL, glicose 64 mg/dL (glicemia 110 mg/dL). Iniciou aciclovir IV na admissão. No segundo dia de internação, chega a PCR para herpes simples no líquor: negativa. EEG: descargas epileptiformes periódicas lateralizadas à esquerda. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

colhido nas primeiras 24 horas dos sintomas neurológicos

Resolução. A PCR negativa e a celularidade baixa parecem afastar a encefalite herpética e liberar a suspensão do aciclovir. A PCR, porém, pode ser falsamente negativa quando o líquor é colhido nos primeiros dias, sobretudo nas primeiras 24 a 72 horas, e a celularidade pode ser discreta no início. Febre, alteração de comportamento, aura olfatória, lesão temporal medial e insular com restrição à difusão, hemácias no líquor e descargas periódicas lateralizadas compõem alta probabilidade pré-teste. Nesse cenário, mantém-se o aciclovir e repete-se a PCR em 3 a 7 dias; só a segunda PCR negativa, com quadro que se afasta, permite suspender. A encefalite autoimune entra na investigação se a evolução não for compatível, mas não justifica parar o antiviral nem pulsar corticoide agora.

A) Suspender o aciclovir e observar ARMADILHA
Errada. É a armadilha do exame tranquilizador: PCR colhida cedo pode ser falso negativo, e a suspensão expõe a paciente à forma mais letal das encefalites virais.

B) Manter o aciclovir e repetir a PCR CORRETA
Correta. Alta probabilidade clínica e radiológica com PCR precoce negativa: manter o antiviral e repetir a PCR em 3 a 7 dias.

C) Trocar o aciclovir por ganciclovir
Errada. Ganciclovir seria para encefalite por citomegalovírus no imunodeprimido; não há imunodepressão aqui.

D) Pulsoterapia e painel de autoanticorpos
Errada. Seria a linha para encefalite autoimune, considerada se a evolução e a segunda PCR afastarem o herpes; febre e lesão temporal com sangue no líquor mantêm o herpes à frente.

Para levar. Encefalite temporal com PCR para herpes negativa em líquor precoce não autoriza suspender o aciclovir: repete-se a PCR em 3 a 7 dias.

Tunkel AR et al. IDSA Guidelines: The Management of Encephalitis, Clin Infect Dis 2008; Solomon T et al. Management of suspected viral encephalitis in adults, ABN/BIA National Guidelines, J Infect 2012.

Revisa: UERJ recorrente: encefalite herpética; a PCR precoce negativa como exame tranquilizador

---

16

Cronologia **Gabarito B**

Infectologia · Febre maculosa com imunofluorescência não reagente no 6º dia: doxiciclina sem esperar a soroconversão

Mulher de 29 anos, bióloga, fez coleta de campo há 9 dias às margens de um rio em município do interior de São Paulo com grande população de capivaras; não lembra de picada. Há 6 dias tem febre de 39,5 °C, cefaleia intensa, mialgia difusa e náuseas. Na semana anterior à viagem limpou com o pai o porão da casa, que havia alagado, onde viu fezes de roedores. Ao exame, PA 100/60 mmHg, FC 112 bpm, sem sufusão conjuntival, panturrilhas indolores, exantema maculopapular que começou no 3º dia nos punhos e tornozelos e hoje atinge tronco, palmas e plantas, com petéquias nos membros inferiores. Plaquetas 78.000/mm³, sódio 129 mEq/L, AST 110 U/L, creatinina 1,3 mg/dL, CK 190 U/L (referência: até 170), bilirrubina total 0,9 mg/dL. A imunofluorescência indireta para Rickettsia rickettsii resultou IgG não reagente na amostra colhida hoje, no 6º dia de doença. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

IgG não reagente na amostra colhida hoje, no 6º dia de doença

Resolução. O exame sorológico negativo tranquiliza quem não lembra do tempo da resposta imune, e o porão alagado com roedores oferece uma saída para a leptospirose. Os anticorpos da febre maculosa costumam aparecer entre o 7º e o 10º dia, e o diagnóstico sorológico exige duas amostras com intervalo de 14 a 21 dias, mostrando soroconversão ou aumento de quatro vezes no título; uma primeira amostra negativa no 6º dia não exclui nada. O quadro clínico já basta: exposição em área de capivaras, febre alta com cefaleia, exantema que começa nas extremidades e se torna petequial com palmas e plantas, plaquetopenia e hiponatremia. A leptospirose fica menos provável pela ausência de sufusão conjuntival, de dor nas panturrilhas, de icterícia e de CK elevada. Na febre maculosa a letalidade sobe muito quando a doxiciclina começa depois do 5º dia, e o tratamento é iniciado na suspeita, com a segunda amostra colhida depois para confirmação.

A) Ceftriaxona e sorologia para leptospirose
Errada. Seria a conduta na leptospirose (sufusão, mialgia de panturrilha, CK alta, icterícia); betalactâmico não cobre riquétsia, que é intracelular.

B) Doxiciclina já e sorologia pareada em 14 dias CORRETA
Correta. Suspeita clínica de febre maculosa pede doxiciclina imediata; a sorologia pareada em 14 dias confirma depois.

C) Aguardar a segunda amostra sem antibiótico ARMADILHA
Errada. É a armadilha da sorologia negativa precoce: os anticorpos ainda não apareceram no 6º dia, e esperar aumenta a letalidade.

D) Teste NS1 e hidratação antes do antibiótico
Errada. Seria o caminho na dengue sem sinais de alarme, mas o exantema petequial palmoplantar com hiponatremia e a exposição a capivaras apontam riquétsia, e o NS1 perde sensibilidade após o 5º dia.

Para levar. Na febre maculosa, sorologia negativa na primeira semana não descarta: os anticorpos surgem por volta do 7º ao 10º dia. Doxiciclina na suspeita e sorologia pareada depois.

Ministério da Saúde, Guia de Vigilância em Saúde, 6ª ed. (2024), capítulo Febre maculosa; CDC, Diagnosis and Management of Tickborne Rickettsial Diseases, MMWR (2016).

Revisa: S1 q48: febre maculosa x leptospirose, agora o erro é confiar na sorologia precoce e adiar a doxiciclina

17 Nefrologia · Creatinina subindo em usuária de lítio há 22 anos, hipertensa: nefrite intersticial crônica com microcistos, e não nefroesclerose

Rótulo verdadeiro **Gabarito C**

Mulher de 58 anos, com transtorno bipolar em uso de carbonato de lítio há 22 anos, com litemias sempre entre 0,6 e 0,9 mEq/L e nenhum episódio de intoxicação, é encaminhada porque a creatinina subiu de 1,1 para 2,0 mg/dL em 6 anos. É hipertensa há 8 anos, em uso de anlodipino, com PA de 138 × 84 mmHg no consultório. Relata noctúria e sede, com ingestão de cerca de 4 litros de água por dia. Urina: densidade 1,004, sem hematúria, sem cilindros; proteinúria de 24 horas de 0,4 g. Fundoscopia com cruzamentos arteriovenosos patológicos e estreitamento arteriolar. Ultrassonografia: rins simétricos de 9,5 cm, com múltiplos microcistos corticais e medulares de 1 a 2 mm. A equipe solicita biópsia renal para embasar a discussão sobre a suspensão do lítio com o psiquiatra. O achado histológico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

múltiplos microcistos corticais e medulares de 1 a 2 mm

Resolução. A hipertensão de 8 anos e a fundoscopia com cruzamentos patológicos são verdadeiras e convidam a atribuir a perda de função à nefroesclerose hipertensiva. Mas a PA está razoavelmente controlada, a hipertensão é bem mais recente que o lítio e o quadro é dominado por defeito de concentração (densidade 1,004, poliúria, polidipsia), que é o efeito renal mais frequente da droga. O dado que fecha é a imagem: microcistos corticais e medulares de 1 a 2 mm em rins de tamanho normal ou discretamente reduzido são a marca da nefropatia crônica do lítio. Na histologia, o correspondente é nefrite tubulointersticial crônica com fibrose intersticial, atrofia tubular e dilatações microcísticas dos túbulos distais e coletores, com pouca inflamação e glomérulos relativamente preservados. A proteinúria baixa, sem sedimento ativo, combina com doença tubulointersticial; a lesão glomerular pelo lítio existe, mas se apresenta com proteinúria nefrótica.

A) Infiltrado intersticial agudo com eosinófilos
Errada. Seria a nefrite intersticial aguda por droga nova, com piora em semanas e leucocitúria; aqui a queda é lenta, em anos, e o sedimento é inocente.

B) Glomeruloesclerose segmentar e focal colapsante
Errada. A lesão glomerular associada ao lítio (lesão mínima ou GESF) se manifesta com síndrome nefrótica; aqui a proteinúria é de 0,4 g.

C) Fibrose intersticial com microcistos tubulares distais CORRETA
Correta. Lítio por décadas, defeito de concentração, proteinúria baixa e microcistos corticomedulares correspondem a nefrite intersticial crônica com microcistos tubulares distais.

D) Nefroesclerose arteriolar hialina difusa ARMADILHA
Errada. É a armadilha da fundoscopia: seria o achado da nefroesclerose hipertensiva, mas a PA está controlada, o defeito de concentração domina e os microcistos apontam para o lítio.

Para levar. O efeito renal mais frequente do lítio é o defeito de concentração; o mais grave é a nefrite intersticial crônica, lenta, com proteinúria baixa e microcistos tubulares distais visíveis até na ultrassonografia.

Davis J et al. Lithium and nephrotoxicity: a literature review of approaches to clinical management and risk stratification. BMC Nephrol 2018; KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of CKD.

Revisa: UERJ recorrente: nefrotoxicidade crônica do lítio + S1 q5 (efeito renal do lítio confundido com ATR)

---

18 Oncologia · Coronariopata com dor torácica e troponina alta semanas após nivolumabe com ipilimumabe, com ptose e CK alta: miocardite imunomediada, e não síndrome coronariana

Rótulo verdadeiro **Gabarito A**

Homem de 69 anos, com melanoma metastático, recebeu a segunda dose de nivolumabe com ipilimumabe há 18 dias. Tem doença coronariana com stent na artéria descendente anterior há 3 anos, em uso de AAS, atorvastatina 40 mg e metoprolol; cintilografia de perfusão há 4 meses sem isquemia. Há 5 dias refere dor nas coxas, cansaço aos esforços leves e desconforto torácico em aperto, intermitente, e desde ontem visão dupla no fim do dia e pálpebras caídas. Exame: PA 112/70 mmHg, FC 58 bpm, SatO2 95%, ptose bilateral assimétrica, fraqueza proximal grau 4 nos quatro membros, pulmões limpos. ECG: bloqueio atrioventricular de primeiro grau e bloqueio de ramo direito, ambos novos, sem supradesnivelamento de ST. Troponina T ultrassensível 1.150 ng/L (referência até 14), CK 4.200 U/L, TSH normal. Ecocardiograma: fração de ejeção de 52%, sem alteração segmentar nova. A conduta mais adequada neste momento é:

O DADO QUE DECIDE

CK 4.200 U/L

Resolução. Coronariopata com stent, desconforto em aperto e troponina muito alta é o roteiro da síndrome coronariana, e o cateterismo parece inadiável. O resto do caso não cabe numa coronária: o início nas primeiras semanas após o bloqueio combinado de PD-1 e CTLA-4, o distúrbio de condução novo sem alteração segmentar no ecocardiograma e, sobretudo, a CK de 4.200 U/L com fraqueza proximal, ptose e diplopia flutuantes, que juntam miosite, quadro miastênico e miocardite. Essa sobreposição é o efeito adverso imunomediado mais letal dos inibidores de checkpoint. A conduta é suspender definitivamente a imunoterapia, iniciar pulso de metilprednisolona (500 a 1.000 mg/dia), monitorizar o ritmo pelo risco de bloqueio avançado e escalonar (abatacepte, micofenolato, imunoglobulina ou plasmaférese) se não houver resposta. A estatina e a miastenia isolada explicariam parte do quadro, mas nenhuma explica a miocardite.

A) Suspender a imunoterapia e pulso de metilprednisolona CORRETA
Correta. Miocardite com miosite e quadro miastênico após inibidor de checkpoint pede suspensão definitiva e pulso de corticoide, com monitorização do ritmo.

B) Cateterismo e dupla antiagregação plaquetária ARMADILHA
Errada. É a armadilha da coronariopatia; seria a conduta no infarto sem supra de alto risco, mas não há alteração segmentar, e CK alta com ptose e bloqueios novos apontam miocardite imunomediada.

C) Piridostigmina, mantendo a imunoterapia
Errada. Seria um passo sintomático na miastenia autoimune isolada; aqui há miocardite, e manter a imunoterapia é inaceitável.

D) Suspender a atorvastatina e hidratação venosa
Errada. Seria a conduta na miopatia por estatina com rabdomiólise, que não causa ptose, diplopia nem distúrbio de condução.

Para levar. Troponina alta com CK alta, ptose ou diplopia e distúrbio de condução nas primeiras semanas de inibidor de checkpoint (sobretudo combinado) é a tríade miocardite, miosite e miastenia: suspender e pulso de metilprednisolona.

ESC Guidelines on Cardio-oncology (2022); ASCO Guideline on Management of Immune-Related Adverse Events (2021).

Revisa: S4 q62: toxicidade imunomediada por inibidor de checkpoint (antes a hepatite refratária, agora a miocardite rotulada como síndrome coronariana)

19

Endocrinologia · Cetoacidose grave com pH abaixo de 7,0 e potássio de 3,1: repor potássio e adiar a insulina, antes de qualquer bicarbonato

Limiar **Gabarito D**

Mulher de 19 anos, com diabetes tipo 1 há 6 anos, chega com vômitos há 3 dias, dor abdominal difusa e respiração de Kussmaul; vinha aplicando insulina apenas à noite. PA 96 × 58 mmHg, FC 124 bpm, sonolenta, mas obedece a comandos. Glicemia 538 mg/dL, pH 6,96, bicarbonato 4 mEq/L, ânion gap 28, sódio 131 mEq/L, potássio 3,1 mEq/L, fósforo 1,2 mg/dL, creatinina 1,6 mg/dL, beta-hidroxibutirato 7,8 mmol/L. ECG com ondas U discretas, sem arritmia. Já recebeu 1 L de solução salina a 0,9% na primeira hora. A plantonista prepara insulina regular em bolus de 0,1 U/kg seguida de infusão contínua, e o residente sugere bicarbonato de sódio por causa do pH abaixo de 7,0. Além de manter a hidratação, a conduta mais adequada neste momento é:

O DADO QUE DECIDE
potássio 3,1 mEq/L

Resolução. Na cetoacidose, o potássio sérico costuma estar normal ou alto apesar de um déficit corporal grande, porque a acidose e a falta de insulina o mantêm fora das células. Quando ele já chega abaixo de 3,5 mEq/L, o déficit é enorme, e a insulina, ao empurrar potássio para dentro da célula, pode precipitar arritmia e parada respiratória por fraqueza muscular. Por isso a insulina é adiada e o potássio é reposto por via venosa, com monitorização, até passar de 3,5 mEq/L; só então começa a infusão. A tentação de iniciar tudo junto, como se faz com potássio entre 3,5 e 5,2, é a armadilha. O bicarbonato, que o consenso admite considerar com pH abaixo de 7,0, também desloca potássio para dentro da célula e não pode vir antes dessa correção; o fósforo baixo isolado não exige reposição.

A) Bicarbonato e insulina em infusão contínua
Errada. O bicarbonato com pH abaixo de 7,0 é uma possibilidade, mas agrava a hipocalemia e não antecede a correção do potássio; com potássio de 3,1, a insulina também espera.

B) Insulina em bolus e potássio em seguida
Errada. O bolus de insulina é opcional e seria aceitável com potássio acima de 3,5; aqui ele provoca queda brusca do potássio.

C) Insulina contínua junto com potássio venoso ARMADILHA
Errada. É a armadilha: insulina e potássio juntos é a regra quando o potássio está entre 3,5 e 5,2 mEq/L, e não abaixo de 3,5.

D) Potássio venoso, insulina só após 3,5 mEq/L CORRETA

Correta. Com potássio de 3,1 mEq/L, repõe-se potássio por via venosa e a insulina só começa quando ele passar de 3,5.

Para levar. Na cetoacidose, potássio abaixo de 3,5 mEq/L na chegada adia a insulina: repõe-se o potássio primeiro, e o bicarbonato, quando considerado, também espera essa correção.

Umpierrez GE et al. Hyperglycemic crises in adults with diabetes: a consensus report. Diabetes Care 2024; Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes 2025, capítulo de cetoacidose diabética.

Revisa: UERJ recorrente: potássio antes da insulina na cetoacidose, com o pH abaixo de 7,0 como distrator

---

20

Cardiologia · Suspeita de amiloidose cardíaca com proteinúria nefrótica e túnel do carpo: cadeias leves livres e imunofixação antes da cintilografia

Cronologia

Gabarito C

Homem de 63 anos, operado de síndrome do túnel do carpo bilateral há 1 ano, relata dispneia progressiva e edema de membros inferiores há 6 meses, tontura ao levantar e perda de 6 kg. Era hipertenso e suspendeu por conta própria a anlodipina porque a pressão 'caiu sozinha'. Ao exame: PA 98 × 64 mmHg deitado e 78 × 50 mmHg em pé, FC 92 bpm, turgência jugular, hepatomegalia dolorosa, edema 3+/4 até a raiz das coxas, língua de bordos endentados. ECG: baixa voltagem nas derivações periféricas e ondas Q de V1 a V3. Ecocardiograma: septo de 16 mm com aspecto granular, FE de 50% e strain longitudinal reduzido na base com ápice preservado. NT-proBNP 6.800 pg/mL, troponina T 0,08 ng/mL (referência: até 0,014); creatinina 1,4 mg/dL, albumina 2,6 g/dL, proteinúria de 4,2 g/24 h. O exame a ser solicitado em seguida, o mais adequado neste momento, é:

O DADO QUE DECIDE

proteinúria de 4,2 g/24 h

Resolução. O túnel do carpo bilateral operado é verdadeiro e puxa para amiloidose por transtirretina, cujo diagnóstico não invasivo se faz com cintilografia com pirofosfato; esse é o reflexo do apressado. O padrão de strain com ápice preservado, a baixa voltagem com septo espesso e a hipotensão confirmam amiloidose cardíaca, mas não dizem o tipo, e o túnel do carpo também ocorre na amiloidose AL. A proteinúria nefrótica com hipoalbuminemia, a perda de peso, a macroglossia (língua endentada) e a disautonomia apontam para doença sistêmica por cadeias leves, que acomete rim e nervo autonômico, ao contrário da ATTR, que poupa o glomérulo. Por isso, diante de qualquer suspeita de amiloidose cardíaca, o primeiro passo é excluir a proteína monoclonal com cadeias leves livres no soro e imunofixação no soro e na urina: a cintilografia só define ATTR quando esse rastreio é negativo, pois a AL também pode captar o radiotraçador. Com o rastreio positivo, segue-se a biópsia (de gordura abdominal, renal ou endomiocárdica) com tipagem, e a AL é emergência hematológica.

A) Ressonância cardíaca com realce tardio

Errada. A ressonância reforça o diagnóstico de infiltração (realce subendocárdico difuso), mas não distingue AL de ATTR, e o diagnóstico de amiloidose já é muito provável.

B) Sequenciamento do gene da transtirretina

Errada. O sequenciamento vem depois de confirmada a ATTR, para separar a forma hereditária da selvagem.

C) Cadeias leves livres e imunofixação sérica e urinária CORRETA

Correta. Proteinúria nefrótica, macroglossia e disautonomia sugerem AL; o rastreio de cadeias leves vem antes de qualquer outro passo.

D) Cintilografia óssea com pirofosfato de tecnécio ARMADILHA

Errada. É a armadilha do túnel do carpo; a cintilografia só fecha ATTR sem biópsia se a pesquisa de proteína monoclonal for negativa, o que ainda não foi feito.

Para levar. Na suspeita de amiloidose cardíaca, primeiro cadeias leves livres e imunofixação sérica e urinária; só com esse rastreio negativo a cintilografia com pirofosfato diagnostica ATTR. Proteinúria nefrótica fala a favor de AL.

Garcia-Pavia P et al. Diagnosis and treatment of cardiac amyloidosis: a position statement of the ESC Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases. Eur Heart J 2021; 2023 ACC Expert Consensus Decision Pathway on Comprehensive Multidisciplinary Care for the Patient With Cardiac Amyloidosis; Diretriz sobre Diagnóstico e Tratamento da Amiloidose Cardíaca, SBC 2021.

Revisa: UERJ recorrente: amiloidose cardíaca (apical sparing, AL x ATTR), agora pela ordem dos exames

---

21

Reumatologia · Granulomatose eosinofílica com poliangeíte ANCA negativa com miocardite, rotulada como aspergilose broncopulmonar alérgica: ciclofosfamida na indução

Rótulo verdadeiro

Gabarito C

Homem de 44 anos, com asma de início aos 38 anos e polipose nasal operada duas vezes, em uso de budesonida-formoterol, apresenta há 2 meses tosse e infiltrados pulmonares que mudam de lugar entre radiografias, com eosinófilos de 4.800/mm³ (34%). A pneumologia levantou aspergilose broncopulmonar alérgica: IgE total de 1.900 UI/mL e IgE específica para Aspergillus fumigatus de 0,9 kUA/L (referência: abaixo de 0,35). ANCA por imunofluorescência, anti-MPO e anti-PR3 não reagentes. Há 10 dias, dispneia aos pequenos esforços e edema de membros inferiores. PA 118 × 76 mmHg, FC 104 bpm, sem déficit neurológico. Troponina I de 0,9 ng/mL (referência: abaixo de 0,04), creatinina 0,9 mg/dL, urina tipo 1 normal. Ecocardiograma com fração de ejeção de 35% e hipocinesia difusa; coronariografia sem lesões; RM cardíaca com realce tardio subendocárdico difuso, de distribuição não coronariana. Além do glicocorticoide em dose alta, a conduta de indução mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

RM cardíaca com realce tardio subendocárdico difuso, de distribuição não coronariana

Resolução. A IgE total alta e a IgE específica para Aspergillus discretamente positiva são verdadeiras e puxam para aspergilose broncopulmonar alérgica, mas sensibilização a fungo é comum na asma eosinofílica e a aspergilose não causa miocardite. Asma de início tardio, polipose, eosinofilia acima de 10% e infiltrados migratórios fecham granulomatose eosinofílica com poliangeíte, e o ANCA negativo não afasta: cerca de 60% dos pacientes são ANCA negativos, justamente o fenótipo com mais acometimento cardíaco. Troponina alta, fração de ejeção de 35%, coronárias normais e realce tardio não coronariano indicam miocardite eosinofílica, que é doença grave com risco de morte (Five Factor Score positivo). Doença grave se induz com glicocorticoide em dose alta associado a ciclofosfamida (o rituximabe é a outra opção das diretrizes), e o acometimento cardíaco é o cenário em que a ciclofosfamida tem mais respaldo. Os biológicos anti-IL-5 e anti-IgE ficam para doença não grave, recidivante ou dependente de corticoide.

A) Mepolizumabe 300 mg mensal

Errada. O mepolizumabe é indicado na doença recidivante ou refratária sem acometimento grave de órgão; a miocardite com disfunção ventricular exige indução com citotóxico.

B) Itraconazol oral por 16 semanas ARMADILHA

Errada. Seria o tratamento da aspergilose broncopulmonar alérgica, sugerida pela IgE específica positiva; aspergilose não explica miocardite com realce não coronariano e eosinofilia de 34%.

C) Ciclofosfamida intravenosa CORRETA

Correta. Miocardite com fração de ejeção de 35% é doença grave pelo Five Factor Score, e a indução é glicocorticoide com ciclofosfamida, independentemente do ANCA.

D) Omalizumabe subcutâneo

Errada. O anti-IgE trata asma alérgica grave e tem uso esporádico em formas leves; não controla vasculite com risco de vida.

Para levar. Na granulomatose eosinofílica com poliangeíte, o ANCA negativo não afasta o diagnóstico e se associa a coração; miocardite é doença grave e pede glicocorticoide com ciclofosfamida (ou rituximabe), e não biológico anti-IL-5.

Chung SA et al. 2021 ACR/Vasculitis Foundation Guideline for the Management of ANCA-Associated Vasculitis; Hellmich B et al. EULAR recommendations for the management of ANCA-associated vasculitis, 2022 update; Emmi G et al. EGPA consensus task force recommendations, Nat Rev Rheumatol 2023.

Revisa: S4 q40: EGPA ANCA negativa sob rótulo de ABPA, agora no degrau seguinte (gravidade pelo coração define a indução)

22

Hematologia · Anemia hemolítica autoimune quente com angina e prova cruzada incompatível com todas as unidades: transfundir, sem esperar unidade compatível

Negativo no meio | Gabarito A

Mulher de 34 anos, sem comorbidades, nunca engravidou e nunca recebeu transfusão. Há 6 dias tem fadiga, icterícia e urina escura, e desde ontem dispneia e opressão torácica ao caminhar até o banheiro. Exame: FC 132 bpm, PA 102 × 60 mmHg, SpO2 95%, icterícia 2+/4, palidez acentuada, baço palpável a 2 cm do rebordo. ECG com taquicardia sinusal e infradesnível de ST de 1 mm em V4 a V6; troponina discretamente elevada. Exames: Hb 4,4 g/dL, reticulócitos 16%, LDH 1.150 U/L, bilirrubina indireta 4,9 mg/dL, haptoglobina indetectável, esferócitos no esfregaço, Coombs direto IgG 4+ e C3d negativo. Recebeu metilprednisolona há 10 horas. O banco de sangue informa autoanticorpo pan-reativo no soro e no eluato, com prova cruzada incompatível com todas as unidades testadas, e que a técnica de adsorção para excluir aloanticorpo levará cerca de 24 horas. A conduta mais adequada neste momento é:

> O DADO QUE DECIDE
>
> *nunca engravidou e nunca recebeu transfusão*

Resolução. A prova cruzada incompatível com todas as unidades assusta e faz parecer prudente esperar a adsorção ou o efeito do corticoide. Na anemia hemolítica autoimune quente, porém, a incompatibilidade é esperada: o autoanticorpo reage com quase todas as hemácias, inclusive as do doador, e a hemácia transfundida sobrevive tanto quanto a do próprio paciente. O risco real é um aloanticorpo escondido pelo autoanticorpo, e ele depende de aloimunização prévia por gestação ou transfusão, que esta paciente nunca teve. Com hemoglobina de 4,4 g/dL e isquemia miocárdica, o risco de não transfundir supera em muito o

risco de reação: transfunde-se o volume mínimo para aliviar a isquemia, com hemácias ABO e RhD compatíveis (de preferência fenotipadas para Rh e Kell), infusão lenta e vigilância, enquanto o corticoide age. A plasmaférese tem pouco papel nos anticorpos IgG quentes, que se distribuem fora do plasma, e a imunoglobulina tem efeito modesto e lento nesse cenário.

A) Transfundir hemácias ABO e RhD compatíveis, lentamente CORRETA

Correta. Com isquemia miocárdica e sem gestação ou transfusão prévia (baixo risco de aloanticorpo), a transfusão não se adia por causa da prova cruzada incompatível.

B) Plasmaférese de urgência antes de transfundir

Errada. Seria uma opção de resgate na hemólise por crioaglutinina grave, em que o anticorpo IgM fica no plasma; no anticorpo quente IgG o efeito é pequeno e não substitui a transfusão.

C) Manter o corticoide e aguardar a adsorção ARMADILHA

Errada. É a armadilha: aguardar a adsorção seria razoável na paciente estável e politransfundida ou multípara, mas aqui a anemia já produz isquemia miocárdica.

D) Imunoglobulina intravenosa sem transfusão

Errada. A imunoglobulina tem resposta inconstante e lenta na anemia hemolítica autoimune quente, e não corrige em horas uma anemia com isquemia.

Para levar. Na anemia hemolítica autoimune com anemia ameaçadora, prova cruzada incompatível não é motivo para negar transfusão: transfunde-se o mínimo necessário, devagar, e o risco de aloanticorpo depende de gestação ou transfusão prévia.

Hill QA et al. The diagnosis and management of primary autoimmune haemolytic anaemia. British Society for Haematology guideline 2017; Jäger U et al. Diagnosis and treatment of autoimmune hemolytic anemia in adults: recommendations from the First International Consensus Meeting. Blood Rev 2020.

Revisa: UERJ recorrente: anemia hemolítica autoimune e hemoterapia, a transfusão que não se adia pela prova cruzada

---

23 Infectologia · Enterocolite neutropênica com apêndice normal e pesquisa de C. difficile pendente: cobertura anaeróbia e tratamento clínico

Rótulo verdadeiro **Gabarito C**

Homem de 52 anos, com leucemia mieloide aguda, está no 12º dia após indução com citarabina e daunorrubicina. Há 2 dias tem febre e está em uso de cefepima; hoje surgiram dor intensa em fossa ilíaca direita, distensão abdominal e diarreia aquosa, 5 episódios. Temperatura 38,7 °C, PA 108/66 mmHg, FC 112 bpm; abdome distendido, doloroso à palpação profunda da fossa ilíaca direita, sem defesa difusa e com ruídos diminuídos. Neutrófilos 80/mm³, plaquetas 18.000/mm³, lactato 1,8 mmol/L. TC de abdome: espessamento parietal do ceco e do cólon ascendente de 14 mm, com densificação da gordura pericecal, sem pneumoperitônio e sem coleção; apêndice com 6 mm de diâmetro, sem apendicolito. Hemoculturas em andamento; pesquisa de toxina de Clostridioides difficile solicitada, ainda sem resultado. A conduta mais adequada neste momento é:

O DADO QUE DECIDE

espessamento parietal do ceco e do cólon ascendente de 14 mm

Resolução. A diarreia sob antibiótico, com a pesquisa de toxina pendente, faz pensar em Clostridioides difficile, e acrescentar vancomicina oral à cefepima parece cobrir tudo. Mas o paciente neutropênico

profundo, com dor em fossa ilíaca direita e espessamento parietal do ceco acima de 10 mm na TC, tem enterocolite neutropênica (tiflite), infecção polimicrobiana da parede com anaeróbios, bacilos Gram-negativos e às vezes Clostridium septicum. A cefepima não cobre anaeróbios, e a vancomicina oral só age na luz contra C. difficile, sem tratar a infecção da parede. O tratamento é clínico: antimicrobiano com cobertura de Pseudomonas e anaeróbios (piperacilina-tazobactam ou carbapenêmico, ou cefepima com metronidazol), jejum, descompressão se necessário, correção de plaquetas e suporte. A cirurgia fica para perfuração, sangramento persistente ou deterioração apesar do tratamento, e a colonoscopia está contraindicada pelo risco de perfuração.

A) Apendicectomia videolaparoscópica de urgência
Errada. Seria a conduta na apendicite, mas o apêndice tem 6 mm sem apendicolito, e operar o neutropênico sem perfuração aumenta a mortalidade.

B) Manter cefepima e associar vancomicina oral ARMADILHA
Errada. É a armadilha da diarreia sob antibiótico: trataria só a colite por C. difficile e deixa a infecção da parede cecal sem cobertura anaeróbia.

C) Piperacilina-tazobactam, jejum e suporte clínico CORRETA
Correta. Enterocolite neutropênica sem perfuração: betalactâmico antipseudomonas com ação anaeróbia, jejum e suporte.

D) Colonoscopia com biópsia do ceco
Errada. Seria útil para colite por citomegalovírus ou doença inflamatória, mas na parede cecal necrosada do neutropênico o risco de perfuração a contraindica.

Para levar. Neutropênico com dor em fossa ilíaca direita e ceco espessado acima de 10 mm tem tiflite: cobertura anaeróbia e antipseudomonas, tratamento clínico, cirurgia só para perfuração ou sangramento.

IDSA Clinical Practice Guideline for the Use of Antimicrobial Agents in Neutropenic Patients with Cancer (2010, revisão 2023 em andamento); ECIL/ESMO Management of febrile neutropenia (2023); NCCN Prevention and Treatment of Cancer-Related Infections (2025).

Revisa: UERJ recorrente: imunossuprimido muda o agente e a conduta (tiflite), com o rótulo de C. difficile e de apendicite

---

24

Gastroenterologia e hepatologia · Agudização de retocolite após antibiótico com toxina de C. difficile positiva e sem pseudomembranas: vancomicina oral antes de escalar imunossupressão

Negativo no meio | Gabarito D

Mulher de 34 anos, com retocolite ulcerativa extensa diagnosticada há 6 anos, em remissão clínica e endoscópica há 2 anos com mesalazina 4 g/dia, procura atendimento por 8 evacuações diárias com sangue, urgência e cólicas há 9 dias. Concluiu há 12 dias amoxicilina-clavulanato por 7 dias para sinusite. Nega viagens e uso de anti-inflamatórios. Temperatura de 37,8 °C, FC 94 bpm, PA 118/72 mmHg, abdome doloroso em fossa ilíaca esquerda, sem distensão. Hb 11,8 g/dL, leucócitos 14.200/mm³, PCR 48 mg/L, albumina 3,6 g/dL, calprotectina fecal 1.450 µg/g. Coprocultura negativa; GDH e toxinas A/B de Clostridioides difficile positivas nas fezes. Retossigmoidoscopia flexível: eritema, friabilidade e ulcerações rasas contínuas desde o reto, sem pseudomembranas (Mayo endoscópico 2); biópsias sem inclusões virais. Radiografia de abdome sem dilatação colônica. Além de manter a mesalazina, a conduta inicial mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

GDH e toxinas A/B de Clostridioides difficile positivas nas fezes

Resolução. Sangramento, urgência, calprotectina alta e mucosa com aspecto de retocolite ativa, sem pseudomembranas, empurram para agudização da doença e corticoide sistêmico. Mas a ausência de pseudomembranas é a regra, e não a exceção, na infecção por C. difficile em quem tem doença inflamatória intestinal, e o achado endoscópico não separa as duas. A crise veio logo após antibiótico, e o rastreio com GDH e toxinas positivas confirma infecção ativa, que nesta população piora o curso e aumenta o risco de colectomia. O tratamento é antimicrobiano dirigido, com vancomicina oral (ou fidaxomicina), mantendo a mesalazina, e reavaliação em 48 a 72 horas; o corticoide iniciado antes de tratar a infecção agrava a colite. A escalada da imunossupressão fica para quem não melhora com o tratamento da infecção.

A) Indução com infliximabe intravenoso
Errada. Seria o degrau para retocolite moderada a grave refratária ao corticoide; iniciar biológico com infecção ativa não tratada não se justifica.

B) Metronidazol oral por 10 dias
Errada. Metronidazol oral deixou de ser primeira linha pela menor eficácia; ficaria só sem acesso a vancomicina ou fidaxomicina.

C) Prednisona oral 40 mg ao dia ARMADILHA
Errada. É a armadilha das mucosas sem pseudomembranas: seria a conduta para agudização moderada sem infecção, mas aqui a toxina é positiva.

D) Vancomicina oral por 10 dias CORRETA
Correta. Infecção por C. difficile confirmada em paciente com retocolite se trata com vancomicina oral (ou fidaxomicina), sem escalar imunossupressão de início.

Para levar. Toda agudização de doença inflamatória intestinal pede pesquisa de C. difficile, e a falta de pseudomembranas não a afasta; com toxina positiva, trate a infecção antes de escalar a imunossupressão.

ACG Clinical Guideline: Prevention, Diagnosis, and Treatment of Clostridioides difficile Infections, 2021; IDSA/SHEA Focused Update, 2021; ECCO Guidelines on Ulcerative Colitis, 2022.

Revisa: UERJ recorrente: C. difficile após antibiótico, aqui mascarado por agudização de retocolite

---

25 Pneumologia · Exacerbação de DPOC com hiperóxia e PaCO2 alta, mas pH compensado: titular o oxigênio para 88% a 92%, sem suspender e sem VNI imediata

Grade X / Y Gabarito A

Mulher de 71 anos, com DPOC grave (VEF1 de 32% do previsto) em oxigenoterapia domiciliar a 1 L/min, é trazida pelo SAMU por piora da dispneia e do escarro há 3 dias. Na ambulância recebeu máscara com reservatório a 15 L/min, mantida na chegada. Está alerta, orientada, conversando em frases completas, FR 24 irpm, FC 104 bpm, PA 138 × 82 mmHg, SpO2 99%, sem uso de musculatura acessória intenso e sem respiração paradoxal. Gasometria arterial com a máscara: pH 7,37, PaCO2 61 mmHg, PaO2 142 mmHg, bicarbonato 35 mEq/L. A gasometria de 2 meses atrás, em ar ambiente na consulta, mostrava PaCO2 de 54 mmHg e bicarbonato de 33 mEq/L. Radiografia de tórax sem consolidação nem pneumotórax. Já recebeu salbutamol e ipratrópio inalatórios

e prednisona. Quanto ao oxigênio e à ventilação não invasiva, a conduta mais adequada neste momento é, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

pH 7,37

Resolução. A PaCO2 de 61 mmHg e o oxigênio em alto fluxo levam a pensar em VNI, mas a indicação de ventilação não invasiva na exacerbação é a acidose respiratória (pH igual ou menor que 7,35 com PaCO2 acima de 45 mmHg), e o pH aqui é 7,37, com bicarbonato alto que mostra retenção crônica compensada, próxima do basal dela. O problema real é a hiperóxia: PaO2 de 142 mmHg num retentor crônico piora a relação ventilação-perfusão (perda da vasoconstrição hipóxica), desloca CO2 pelo efeito Haldane e pode levar à acidose. A conduta é reduzir a fração inspirada, de preferência com máscara de Venturi, mirando SpO2 de 88% a 92%, e repetir a gasometria em 30 a 60 minutos. Suspender o oxigênio de vez é perigoso: a PaO2 cai abaixo do basal antes de a PaCO2 baixar, com hipoxemia de rebote. Se a nova gasometria mostrar pH de 7,35 ou menos, aí a VNI entra.

A) Titular para SpO2 88% a 92% / sem VNI agora CORRETA

Correta. Hiperóxia num retentor crônico com pH ainda compensado (7,37): baixar a FiO2 para o alvo de 88% a 92% e regasometrar; ainda não há critério de VNI.

B) Suspender o oxigênio / sem VNI agora

Errada. Suspender o oxigênio na hipercapnia provoca hipoxemia de rebote, mais grave que a de partida; reduz-se a FiO2, não se retira.

C) Titular para SpO2 88% a 92% / VNI imediata ARMADILHA

Errada. É a armadilha: a titulação está certa, mas a VNI seria indicada com pH igual ou menor que 7,35; a PaCO2 alta com bicarbonato de 35 mEq/L é retenção crônica compensada.

D) Manter a máscara com reservatório / VNI imediata

Errada. Manter a máscara com reservatório perpetua a hiperóxia que ameaça elevar a PaCO2; VNI não corrige o excesso de oxigênio e não tem indicação com este pH.

Para levar. Na exacerbação da DPOC, o alvo de SpO2 é 88% a 92%: diante de hiperóxia, reduz-se a FiO2 sem suspender o oxigênio, e a VNI se indica pelo pH (igual ou menor que 7,35), não pelo valor isolado da PaCO2.

GOLD 2025/2026; BTS Guideline for oxygen use in adults in healthcare and emergency settings (2017); ERS/ATS Guidelines for noninvasive ventilation in acute respiratory failure (2017).

Revisa: UERJ recorrente: oxigenoterapia na DPOC hipercápnica, reduzir e não suspender, e o pH como critério de VNI

---

26 Neurologia · Papiledema no homem obeso em uso de testosterona com hematócrito de 57%: venografia antes de aceitar o rótulo de hipertensão intracraniana idiopática

Rótulo verdadeiro | Gabarito B

Homem de 38 anos, fisiculturista, procura o ambulatório por cefaleia holocraniana há 5 semanas, pior ao deitar e ao tossir, com escurecimentos visuais de segundos ao se levantar e zumbido pulsátil à direita. Usa por conta própria cipionato de testosterona 250 mg por semana há 8 meses, associado a oxandrolona. A esposa relata roncos altos com pausas respiratórias. IMC 31 kg/m², PA 138/86 mmHg, FC 72 bpm. Papiledema bilateral grau III

e paresia do VI nervo à esquerda, sem outros déficits. Hemograma: hemoglobina 18,9 g/dL, hematócrito 57%, plaquetas 260.000/mm³. TC de crânio sem contraste e RM de encéfalo sem contraste: parênquima normal, sela parcialmente vazia e achatamento posterior dos globos oculares. O neurologista assistente registra 'hipertensão intracraniana idiopática em paciente obeso' e prescreve acetazolamida após a punção lombar com manometria, já agendada. O próximo passo mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

hematócrito 57%

Resolução. Obesidade, papiledema, VI nervo e imagem com sela vazia e achatamento dos globos formam o quadro que o assistente rotulou, e a punção com manometria parece o passo seguinte natural. Esses sinais, porém, indicam pressão intracraniana alta de qualquer causa, e a RM sem fase venosa não exclui trombose dos seios durais. Neste homem há dois fatores trombóticos: o androgênio exógeno e a policitemia secundária a ele, com hematócrito de 57%, além do zumbido pulsátil. O sexo masculino é incomum na hipertensão intracraniana idiopática, o que reforça a busca de causa secundária. A punção mostraria pressão alta nas duas doenças e não as separa; a venografia por RM (ou angio-TC venosa) vem antes, porque a trombose muda a conduta para anticoagulação. A apneia do sono é causa de pressão intracraniana elevada a ser investigada depois, não o passo que exclui a doença grave.

A) Punção lombar com manometria ARMADILHA
Errada. Confirma pressão de abertura alta, mas não distingue a forma idiopática da trombose venosa; só se faz depois da venografia normal.

B) Venografia por ressonância magnética CORRETA
Correta. Androgênio exógeno e hematócrito de 57% tornam a trombose dos seios durais plausível, e a RM sem fase venosa não a exclui.

C) Acetazolamida e perda de peso
Errada. Seria o tratamento da hipertensão intracraniana idiopática confirmada, depois de excluir causa secundária.

D) Polissonografia de noite inteira
Errada. A apneia do sono pode elevar a pressão intracraniana e merece estudo, mas não exclui a trombose venosa, que é a causa a afastar primeiro.

Para levar. Papiledema com TC e RM sem contraste normais não é hipertensão intracraniana idiopática até a venografia excluir trombose venosa cerebral, sobretudo no homem, com androgênio ou policitemia.

Mollan SP et al. Idiopathic intracranial hypertension: consensus guidelines on management. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2018; Saposnik G et al. AHA Scientific Statement on Cerebral Venous Thrombosis, Stroke 2024.

Revisa: S1 q19: a venografia vem antes da punção; o cenário agora é o homem com androgênio e policitemia, sem anticoncepcional

27 Nefrologia · Microangiopatia trombótica no puerpério sem resposta à plasmaférese, com ADAMTS13 de 64% e C3 baixo: SHU atípica e inibidor de C5

Grade X / Y **Gabarito A**

Mulher de 27 anos, 5 semanas após parto vaginal sem intercorrências, com pré-natal normal e sem pré-eclâmpsia, procura a emergência por astenia, edema e redução da diurese há 4 dias. Teve dois episódios de fezes amolecidas, sem sangue, na semana anterior. PA 168 × 104 mmHg, afebril, sem alteração neurológica. Hemoglobina 7,1 g/dL com esquizócitos, plaquetas 62.000/mm³, LDH 1.840 U/L, haptoglobina indetectável, Coombs direto negativo, creatinina 4,6 mg/dL, C3 58 mg/dL (90 a 180), C4 normal. O plantão iniciou plasmaférese diária com a hipótese de púrpura trombocitopênica trombótica; após 5 sessões, plaquetas de 70.000/mm³ e creatinina de 4,9 mg/dL. Chega então o resultado da atividade de ADAMTS13 colhida antes da primeira sessão: 64%. Pesquisa de Shiga toxina nas fezes negativa. O diagnóstico e a conduta mais adequada neste momento são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

atividade de ADAMTS13 colhida antes da primeira sessão: 64%

Resolução. A plasmaférese iniciada às cegas foi correta, porque a PTT mata em horas e não se espera o ADAMTS13; o erro é manter o rótulo depois do resultado. Atividade de ADAMTS13 colhida antes da plasmaférese acima de 10% (aqui 64%) exclui PTT, e com Shiga toxina negativa e diarreia discreta, sem sangue, a SHU por STEC também sai. Microangiopatia com lesão renal grave, hipertensão, C3 baixo e C4 normal no puerpério é SHU atípica mediada por complemento, com frequência desencadeada pela gestação. A falta de resposta renal à plasmaférese é esperada: o tratamento de escolha é o bloqueio do C5 com eculizumabe (ou ravulizumabe), iniciado o quanto antes para preservar o rim, com vacinação antimeningocócica e profilaxia antibiótica.

A) SHU atípica / eculizumabe CORRETA
Correta. ADAMTS13 acima de 10%, Shiga toxina negativa, lesão renal dominante e C3 baixo no puerpério definem SHU atípica, tratada com inibidor de C5.

B) PTT adquirida / caplacizumabe ARMADILHA
Errada. É a armadilha do rótulo do plantão: caplacizumabe com plasmaférese seria para PTT adquirida, que exige ADAMTS13 abaixo de 10%.

C) SHU atípica / plasmaférese mantida
Errada. O diagnóstico está certo, mas plasmaférese mantida só seria aceitável sem acesso ao inibidor de C5; ela não recupera a função renal na SHU atípica.

D) SHU por Shiga toxina / suporte
Errada. Seria a conduta na SHU por STEC, com diarreia sanguinolenta e toxina presente; aqui a toxina é negativa e a diarreia foi mínima.

Para levar. Na microangiopatia trombótica, ADAMTS13 acima de 10% tira a PTT; sem Shiga toxina, com rim dominante e gatilho como o puerpério, é SHU atípica, e o tratamento é o inibidor de C5, e não plasmaférese indefinida.

Goodship THJ et al. Atypical hemolytic uremic syndrome and C3 glomerulopathy: KDIGO Controversies Conference. Kidney Int 2017; KDIGO 2021 Clinical Practice Guideline for the Management of Glomerular Diseases.

Revisa: UERJ recorrente: SHU atípica; padrão do aluno de manter o rótulo inicial (S1 q37, S3 q16)

28 Reumatologia · Doença por depósito de pirofosfato antes dos 55 anos com hipomagnesemia e hipocalciúria: síndrome de Gitelman, e não hemocromatose pela ferritina alta

Limiar **Gabarito B**

Homem de 38 anos tem o terceiro episódio, em 2 anos, de monoartrite aguda do joelho. A artrocentese mostra cristais romboides com birrefringência fracamente positiva, 18.000 leucócitos/mm³, Gram e cultura negativos. Radiografias: condrocalcinose meniscal bilateral e na fibrocartilagem triangular dos punhos. Relata cãibras frequentes e fadiga desde a adolescência; nega uso de diuréticos, laxativos ou álcool em excesso. PA 104 × 66 mmHg, sem hepatomegalia, pele sem hiperpigmentação. Sódio 138 mEq/L, potássio 2,9 mEq/L, bicarbonato 31 mEq/L, magnésio 1,1 mg/dL (referência: 1,7 a 2,4), cálcio 9,4 mg/dL, PTH 42 pg/mL, TSH normal. Ferritina 520 ng/mL (referência: 30 a 400) com saturação de transferrina de 29%, colhidas durante a crise. Cálcio urinário de 40 mg/24 h. A causa subjacente mais provável da doença por depósito de pirofosfato é:

O DADO QUE DECIDE

saturação de transferrina de 29%

Resolução. Doença por depósito de pirofosfato antes dos 55 anos obriga a procurar causa metabólica, e a ferritina acima da referência puxa para hemocromatose. Só que a ferritina é reagente de fase aguda e foi colhida na crise; o que define sobrecarga de ferro é a saturação de transferrina acima de 45%, e 29% está normal. O que sobra é hipomagnesemia: o magnésio é cofator das pirofosfatases, e sua falta acumula pirofosfato na cartilagem. Hipocalemia, alcalose metabólica, pressão baixa, hipomagnesemia e hipocalciúria, sem diurético, desde a adolescência, são a síndrome de Gitelman (defeito do cotransportador sódio-cloro do túbulo distal). A hipocalciúria a separa da síndrome de Bartter, que cursa com cálcio urinário normal ou alto, e o cálcio e o PTH normais afastam hiperparatireoidismo.

A) Hemocromatose hereditária ARMADILHA
Errada. Seria a causa se a saturação de transferrina passasse de 45%; a ferritina alta colhida na crise é reação de fase aguda.

B) Síndrome de Gitelman CORRETA
Correta. Hipomagnesemia com hipocalemia, alcalose e hipocalciúria sem diurético é Gitelman, e o magnésio baixo favorece o depósito de pirofosfato.

C) Hiperparatireoidismo primário
Errada. É causa conhecida de condrocalcinose, mas pediria cálcio ou PTH elevados, normais aqui.

D) Síndrome de Bartter
Errada. Também cursa com hipocalemia e alcalose, mas com cálcio urinário normal ou alto e magnésio em geral normal; a hipocalciúria fala contra.

Para levar. Pirofosfato antes dos 55 anos: dosar magnésio, cálcio, PTH, fosfatase alcalina e saturação de transferrina. Hipomagnesemia com hipocalciúria e alcalose aponta Gitelman; ferritina alta isolada, colhida na crise, não é hemocromatose.

Zhang W et al. EULAR recommendations for calcium pyrophosphate deposition, Ann Rheum Dis 2011; Tedeschi SK et al. 2023 ACR/EULAR classification criteria for CPPD disease; Blanchard A et al. Gitelman syndrome: consensus and guidance from KDIGO, Kidney Int 2017.

Revisa: UERJ recorrente: gota, pirofosfato e artrite séptica (causa secundária da doença por pirofosfato no jovem); padrão do aluno de aceitar o laboratório que imita outra doença

29 Cardiologia · Insuficiência cardíaca nova no diabético com edema atribuído ao anlodipino: suspender a pioglitazona

Droga a deduzir **Gabarito C**

Homem de 66 anos, diabético há 12 anos, hipertenso e com angina estável controlada, usa metformina 850 mg de 12 em 12 horas, losartana 100 mg/dia, anlodipino 10 mg/dia, AAS 100 mg/dia, atorvastatina 40 mg/dia e pioglitazona 45 mg/dia, esta acrescentada há 4 meses por hemoglobina glicada de 8,4%. Nos últimos 3 meses ganhou 5 kg e notou edema de membros inferiores até os joelhos; a enfermeira da unidade atribuiu o edema ao anlodipino, que ele usa há 6 anos. Há 3 semanas tem dispneia aos esforços moderados e precisa de dois travesseiros para dormir. Ao exame: PA 138 × 84 mmHg, FC 88 bpm, SatO2 95%, turgência jugular a 45 graus, estertores crepitantes nas bases, terceira bulha e edema 2+/4 depressível. Creatinina 1,3 mg/dL (TFGe 58 mL/min/1,73 m²), potássio 4,6 mEq/L, NT-proBNP 2.100 pg/mL, hemoglobina glicada atual de 7,1%. Ecocardiograma: FE de 46%, sem valvopatia. Entre os medicamentos em uso, o que deve ser suspenso é:

O DADO QUE DECIDE

esta acrescentada há 4 meses

Resolução. O edema do anlodipino é real e frequente, e a enfermeira tem uma explicação pronta; mas edema por bloqueador de cálcio di-hidropiridínico é vasodilatação pré-capilar, sem congestão, e não explica turgência jugular, estertores, terceira bulha nem NT-proBNP elevado. O que mudou na cronologia foi a pioglitazona, iniciada 4 meses antes, junto com o ganho de peso e o edema: as glitazonas aumentam a reabsorção de sódio no túbulo coletor e expandem o volume, precipitando ou agravando insuficiência cardíaca. São contraindicadas na insuficiência cardíaca sintomática, e a diretriz recomenda não usá-las nesse paciente. O anlodipino é neutro em insuficiência cardíaca e pode ficar por causa da angina, ao contrário dos bloqueadores de cálcio não di-hidropiridínicos (verapamil, diltiazem), que pioram a disfunção sistólica. Para o controle glicêmico, a troca natural é por um inibidor de SGLT2, que trata ao mesmo tempo a insuficiência cardíaca.

A) Metformina
Errada. Seria suspensa com TFGe abaixo de 30 ou na insuficiência cardíaca descompensada com hipoperfusão e risco de acidose lática; não é o caso.

B) Losartana
Errada. Seria suspensa em hipercalemia grave ou injúria renal aguda; com potássio de 4,6 e TFGe estável, o bloqueio do SRAA deve ser mantido e otimizado.

C) Pioglitazona CORRETA
Correta. Glitazona causa retenção de sódio e insuficiência cardíaca, e o quadro começou depois de sua introdução.

D) Anlodipino ARMADILHA
Errada. É a armadilha do rótulo da enfermeira; o anlodipino é usado há 6 anos, causa edema sem congestão e é neutro na insuficiência cardíaca.

Para levar. Insuficiência cardíaca que surge ou piora após pioglitazona: suspenda a glitazona e troque por iSGLT2. Anlodipino é neutro na IC; o bloqueador de cálcio a evitar é o não di-hidropiridínico.

ADA Standards of Care in Diabetes 2026, seção Cardiovascular Disease and Risk Management; 2022 AHA/ACC/HFSA Guideline for the Management of Heart Failure; Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes 2025.

Revisa: UERJ recorrente: IC com droga que a comorbidade contraindica (pioglitazona x BCC)

---

30 Endocrinologia · Hipoglicemia hiperinsulinêmica com peptídeo C alto em técnica de enfermagem cujo marido usa insulina: origem endógena e pesquisa de sulfonilureia antes de localizar insulinoma

Grade X / Y **Gabarito C**

Mulher de 38 anos, técnica de enfermagem em hospital-dia de diabetes, é levada à emergência pela terceira vez em 2 meses com sudorese, confusão e glicemia capilar de 34 mg/dL, revertidas com glicose venosa. Não tem diabetes, nega etilismo, perda de peso ou cirurgia gástrica. O marido usa insulina glargina e metformina, e o pai, que mora com o casal, usa gliclazida. Na crise atual, antes da glicose: glicemia plasmática 38 mg/dL, insulina 42 µU/mL (esperado em hipoglicemia: abaixo de 3), peptídeo C 4,6 ng/mL (esperado: abaixo de 0,6), pró-insulina 12 pmol/L (esperado: abaixo de 5), beta-hidroxibutirato 0,1 mmol/L e elevação da glicemia de 38 mg/dL após 1 mg de glucagon. Anticorpos anti-insulina negativos. Tomografia de abdome com contraste, feita em outro serviço, sem lesão pancreática. A origem da insulina e o exame mais adequado a seguir são, respectivamente:

> O DADO QUE DECIDE
>
> *o pai, que mora com o casal, usa gliclazida*

Resolução. A profissão e o marido em uso de insulina puxam para hipoglicemia factícia por insulina, e a tomografia normal empurra o apressado para a ecoendoscopia atrás de um insulinoma pequeno. O perfil laboratorial, porém, é de hiperinsulinismo endógeno: peptídeo C e pró-insulina altos junto com a insulina, cetona suprimida e resposta ao glucagon. Insulina exógena suprimiria o peptídeo C, o que não ocorreu. Hiperinsulinismo endógeno tem três causas a separar: insulinoma, nesidioblastose e secretagogo de insulina, e o secretagogo produz exatamente o mesmo perfil bioquímico do insulinoma. Por isso a pesquisa de sulfonilureias e glinidas no plasma, colhido na hipoglicemia, precede qualquer exame de localização, sobretudo quando há gliclazida na casa. Os anticorpos anti-insulina negativos afastam a hipoglicemia autoimune.

A) Exógena / insulina dosada por outro ensaio
Errada. Seria o raciocínio para insulina exógena com peptídeo C suprimido, em que alguns análogos escapam do ensaio; aqui o peptídeo C alto prova secreção endógena.

B) Endógena / ecoendoscopia do pâncreas ARMADILHA
Errada. É a armadilha: a ecoendoscopia é o passo seguinte ao insulinoma bioquímico com tomografia negativa, mas só depois de afastado o secretagogo, que imita o insulinoma no laboratório.

C) Endógena / pesquisa de sulfonilureias no plasma CORRETA
Correta. Peptídeo C e pró-insulina altos indicam secreção endógena, e com gliclazida acessível em casa a sulfonilureia no plasma tem de ser dosada antes de localizar tumor.

D) Exógena / observação sem acesso a insulina
Errada. Seria uma estratégia diante de insulina exógena com peptídeo C suprimido; aqui a insulina não veio de fora.

Para levar. Insulina, peptídeo C e pró-insulina altos na hipoglicemia significam secreção endógena, e o secretagogo produz o mesmo perfil do insulinoma: dose sulfonilureia no plasma antes de qualquer imagem.

Cryer PE et al. Evaluation and management of adult hypoglycemic disorders: Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab 2009; ADA Standards of Care in Diabetes 2026, seção 6.

Revisa: UERJ recorrente: hipoglicemia factícia + S2 q53 (foi para a imagem de pâncreas antes da dosagem de sulfonilureia)

31

Hematologia · Lesão cerebral periventricular homogênea em imunocompetente estável: biópsia estereotáxica antes de qualquer corticoide pela suspeita de linfoma primário do SNC

Rótulo verdadeiro **Gabarito D**

Mulher de 66 anos, hipertensa em uso de hidroclorotiazida, é trazida pela filha por 5 semanas de apatia, esquecimento progressivo e episódios de desorientação. Nega febre, perda de peso, cefaleia intensa e vômitos. Sorologia para HIV não reagente. Exame: Glasgow 15, sem papiledema, sem déficit motor, Mini-Mental 21. A RM de crânio mostra lesão única de 3,2 cm no esplênio do corpo caloso, em contato com o ventrículo, com realce homogêneo pelo gadolínio, restrição à difusão e edema perilesional moderado, com desvio da linha média de 2 mm. A avaliação oftalmológica com lâmpada de fenda é normal. TC de tórax, abdome e pelve sem alterações; LDH 240 U/L. O plantonista prescreveu dexametasona 4 mg de 6 em 6 horas por causa do edema, ainda não administrada. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

Glasgow 15, sem papiledema, sem déficit motor

Resolução. O edema perilesional é verdadeiro e a dexametasona é o reflexo diante de qualquer lesão expansiva, o que torna atraente tratar o edema primeiro e biopsiar depois. Mas lesão periventricular, cruzando o corpo caloso, com realce homogêneo e restrição à difusão em imunocompetente é linfoma primário do SNC até prova em contrário, e o corticoide induz apoptose das células do linfoma: a lesão pode encolher ou sumir e a biópsia vir inconclusiva, atrasando o diagnóstico em semanas. A paciente está consciente, sem papiledema e com desvio mínimo da linha média, ou seja, sem hipertensão intracraniana que obrigue o corticoide agora. A conduta é biópsia estereotáxica sem corticoide e, confirmado o linfoma (quase sempre difuso de grandes células B), quimioterapia baseada em metotrexato em altas doses. A ressecção ampla não melhora a sobrevida nessa doença infiltrativa e multifocal, e a radioterapia de crânio total empírica, sem diagnóstico, causa neurotoxicidade e não é o tratamento inicial.

A) Dexametasona e biópsia após reduzir o edema ARMADILHA
Errada. É a armadilha do edema: o corticoide é necessário quando há herniação iminente, mas antes da biópsia pode desfazer o linfoma e tornar a histologia inconclusiva.

B) Ressecção cirúrgica ampla da lesão
Errada. Seria a abordagem de metástase única ou glioma ressecável; no linfoma primário do SNC a ressecção não muda a sobrevida e acrescenta déficit.

C) Radioterapia de crânio total empírica
Errada. Já foi o tratamento do linfoma primário do SNC e ainda é consolidação em casos selecionados, mas nunca sem diagnóstico histológico e com neurotoxicidade importante no idoso.

D) Biópsia estereotáxica sem corticoide prévio CORRETA
Correta. Paciente sem hipertensão intracraniana grave (Glasgow 15, sem papiledema) deve ser biopsiado antes de qualquer corticoide quando a imagem sugere linfoma.

Para levar. Na suspeita de linfoma primário do SNC, o corticoide espera a biópsia sempre que o paciente estiver estável; o tratamento depois é metotrexato em altas doses, e não cirurgia.

Hoang-Xuan K et al. EANO guidelines for primary CNS lymphoma. Lancet Oncol 2015 e atualização 2023; NCCN Guidelines Central Nervous System Cancers 2025.

Revisa: UERJ recorrente: linfoma primário do SNC, agora no imunocompetente e no momento do corticoide

---

32 Infectologia · Sífilis tratada na pessoa com HIV com VDRL baixo e estável há 2 anos: cicatriz sorológica, sem punção e sem retratamento

Omissão **Gabarito C**

Homem de 41 anos vive com HIV há 8 anos, em uso regular de tenofovir, lamivudina e dolutegravir, com carga viral indetectável e CD4 de 290 células/mm³ no último controle. Há 3 anos teve sífilis secundária, com VDRL de 1:128, tratada com penicilina benzatina 2,4 milhões UI em dose única, com registro de aplicação. Controles do VDRL: aos 6 meses, 1:8; aos 12 meses, 1:4; depois, 1:2, 1:4, 1:2 e 1:2 nos últimos 24 meses. Mantém parceria única estável, cujo teste rápido treponêmico do último mês foi não reagente, e usa preservativo de forma irregular. Nega cefaleia, alteração visual, zumbido ou perda auditiva; exame neurológico e fundoscopia normais, sem lesões cutâneas ou mucosas. Foi encaminhado pela unidade básica porque o VDRL 'continua reagente' e o teste treponêmico permanece reagente. A conduta mais adequada neste momento é:

> O DADO QUE DECIDE
> *aos 6 meses, 1:8*

Resolução. O HIV, o CD4 abaixo de 350 e o VDRL que nunca negativou empurram para investigar neurossífilis por punção lombar, e é aí que o apressado marca. Mas a resposta ao tratamento foi adequada e rápida: de 1:128 para 1:8 em 6 meses, quatro diluições, bem acima do critério de queda de duas diluições. Depois disso o título ficou estável em níveis baixos, e a oscilação entre 1:2 e 1:4 é de uma diluição só, dentro da variação do método, e não conta como elevação, que exige aumento de duas diluições. Sem sintoma neurológico, ocular ou auditivo, sem nova lesão e com parceria testada, o quadro é de cicatriz sorológica, que pode durar a vida toda e não indica retratamento nem punção. O teste treponêmico reagente não ajuda: ele fica positivo para sempre e não serve para seguimento. A conduta é manter o VDRL periódico, e só uma elevação de duas diluições ou sintomas mudam o plano.

A) Penicilina benzatina em três doses semanais
Errada. Seria o retratamento de uma sífilis latente tardia ou de uma falha sem acometimento neurológico; aqui houve queda de quatro diluições em 6 meses e não há falha.

B) Penicilina cristalina intravenosa por 14 dias
Errada. Seria o esquema da neurossífilis ou da sífilis ocular; não há sintoma nem líquor que a sustente.

C) Manter apenas o seguimento sorológico CORRETA

Correta. Queda adequada seguida de título baixo estável, com oscilação de uma diluição só, é cicatriz sorológica: seguimento, sem retratar.

D) Punção lombar antes de decidir o retratamento ARMADILHA

Errada. É a armadilha do HIV: a punção entra na falha sorológica, na elevação de duas diluições ou em sintoma neurológico, ocular ou auditivo, e nada disso existe neste caso.

Para levar. VDRL que caiu duas ou mais diluições e ficou estável em título baixo é cicatriz sorológica, mesmo na pessoa com HIV: oscilação de uma diluição não é falha e não pede punção nem retratamento.

Ministério da Saúde, PCDT para Atenção Integral às Pessoas com IST (2022); CDC Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines (2021).

Revisa: S1 q13 pelo avesso: o critério de resposta sorológica agora separa cicatriz de falha, e a punção vira a armadilha

---

33 Neurologia · AVC ao despertar com oclusão de M1, FLAIR já positivo e mismatch de perfusão: sem trombólise, com trombectomia

Grade X / Y **Gabarito C**

Homem de 67 anos, hipertenso e com fibrilação atrial em uso irregular de apixabana (última dose há 3 dias), foi visto bem pela esposa às 20h, quando foi deitar, e encontrado às 7h com afasia global e hemiplegia direita. Chega ao pronto-socorro às 8h: PA 176/98 mmHg, FC 96 bpm irregular, glicemia capilar 142 mg/dL, NIHSS 19. Creatinina 0,9 mg/dL, plaquetas 210.000/mm³, INR 1,1, TTPa normal. TC sem contraste: ASPECTS 8. Angiotomografia: oclusão do segmento M1 da artéria cerebral média esquerda. RM imediata: lesão em difusão de 18 mL na ínsula e nos núcleos da base, já com hipersinal nítido no FLAIR na mesma área; perfusão com volume hipoperfundido (Tmax acima de 6 s) de 120 mL. Trombólise intravenosa e trombectomia mecânica estão, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

já com hipersinal nítido no FLAIR na mesma área

Resolução. Visto bem há 12 horas, o paciente parece fora de qualquer janela, e o apressado não oferece reperfusão. As duas decisões, porém, têm critérios diferentes. A trombectomia de 6 a 24 horas se decide pela imagem: oclusão de grande vaso proximal, NIHSS alto, núcleo pequeno (18 mL) e área hipoperfundida muito maior (relação de 6,7), dentro dos critérios dos estudos DAWN e DEFUSE 3; está indicada. A trombólise no AVC de início desconhecido só é possível quando a RM mostra lesão na difusão sem correspondente no FLAIR, sinal de que o infarto tem menos de 4,5 horas; aqui o FLAIR já está positivo, o que fecha a trombólise. A apixabana há 3 dias, com função renal normal, não seria impedimento, e a PA abaixo de 185/110 também não.

A) Indicada / indicada

Errada. Seria a resposta com difusão positiva e FLAIR ainda negativo (critério do estudo WAKE-UP); aqui o FLAIR já mostra a lesão.

B) Indicada / contraindicada

Errada. Inverte as decisões: a trombólise é que está fechada pelo FLAIR, e a trombectomia preenche os critérios de imagem da janela tardia.

C) Contraindicada / indicada CORRETA

Correta. FLAIR positivo afasta a trombólise no início desconhecido; oclusão de M1 com núcleo de 18 mL e penumbra de 120 mL indica trombectomia até 24 horas.

D) Contraindicada / contraindicada ARMADILHA

Errada. É a armadilha das 12 horas: a janela da trombectomia é definida pela imagem e vai até 24 horas.

Para levar. No AVC ao despertar, a trombólise depende do descompasso difusão positiva e FLAIR negativo; a trombectomia de 6 a 24 horas depende de oclusão proximal com núcleo pequeno e penumbra grande. São critérios independentes.

Powers WJ et al. AHA/ASA Guidelines for the Early Management of Acute Ischemic Stroke, 2019 update; Thomalla G et al. WAKE-UP, NEJM 2018; Nogueira RG et al. DAWN, NEJM 2018; Albers GW et al. DEFUSE 3, NEJM 2018.

Revisa: UERJ recorrente: trombólise e trombectomia por mismatch, decididas separadamente no AVC de início desconhecido

---

34

Gastroenterologia e hepatologia · Lesão renal no cirrótico sem resposta à albumina, já em terlipressina, com cilindros hemáticos: glomerulonefrite por IgA, e não síndrome hepatorrenal

Rótulo verdadeiro **Gabarito D**

Homem de 56 anos, com cirrose alcoólica Child-Pugh B, abstinente há 8 meses, em uso de espironolactona 100 mg, furosemida 40 mg e propranolol 40 mg ao dia, é internado por aumento do volume abdominal e edema de membros inferiores. Creatinina de 2,4 mg/dL (basal de 1,0 mg/dL há 3 meses), sem uso de anti-inflamatório ou contraste, sem diarreia nem sangramento. Afebril, PA 132/78 mmHg, FC 76 bpm. Paracentese diagnóstica com 60 polimorfonucleares/mm³. Os diuréticos foram suspensos e ele recebeu albumina 1 g/kg por 2 dias, sem queda da creatinina (2,5 mg/dL); a equipe registrou síndrome hepatorrenal e iniciou terlipressina. Sódio urinário de 8 mEq/L. Exame de urina: proteína 2+, 70 hemácias por campo, 80% dismórficas, com cilindros hemáticos; proteinúria de 1,8 g/24 h. C3 discretamente reduzido. Ultrassonografia: rins de 11 cm, sem hidronefrose. A causa mais provável da lesão renal é:

O DADO QUE DECIDE

70 hemácias por campo, 80% dismórficas, com cilindros hemáticos

Resolução. A falta de resposta à expansão com albumina, a suspensão dos diuréticos e o sódio urinário baixo são verdadeiros e lembram síndrome hepatorrenal, rótulo que a equipe já escreveu. Mas o diagnóstico de síndrome hepatorrenal exige ausência de doença renal estrutural: proteinúria acima de 500 mg/dia, hematúria acima de 50 hemácias por campo ou ultrassonografia alterada a afastam. Aqui há proteinúria de 1,8 g/dia, hematúria dismórfica com cilindros hemáticos e C3 baixo, ou seja, glomerulonefrite. No cirrótico, sobretudo alcoólico, a depuração hepática deficiente de imunocomplexos de IgA leva à glomerulopatia por IgA secundária, a glomerulonefrite mais frequente nessa população. O sódio urinário baixo não separa as hipóteses, porque a retenção de sódio da cirrose persiste mesmo com lesão glomerular, e a terlipressina deve ser revista.

A) Nefrite intersticial aguda por diurético

Errada. Nefrite intersticial cursa com leucocitúria, cilindros leucocitários e proteinúria discreta, e não com hemácias dismórficas e cilindros hemáticos.

B) Necrose tubular aguda isquêmica
Errada. Necrose tubular daria cilindros granulosos pigmentados e sódio urinário alto após choque ou nefrotóxico, ausentes aqui.

C) Síndrome hepatorrenal com lesão renal aguda ARMADILHA
Errada. Seria o diagnóstico com sedimento inocente e proteinúria abaixo de 500 mg/dia; hematúria dismórfica com cilindros hemáticos é critério de exclusão.

D) Glomerulonefrite por IgA associada à cirrose CORRETA
Correta. Proteinúria de 1,8 g/dia, hematúria dismórfica, cilindros hemáticos e C3 baixo no cirrótico apontam glomerulonefrite por IgA secundária.

Para levar. Antes de chamar de síndrome hepatorrenal, olhe o sedimento: proteinúria acima de 500 mg/dia ou hematúria acima de 50 hemácias por campo indicam doença renal estrutural, e no cirrótico a glomerulonefrite por IgA é a principal.

International Club of Ascites, critérios de HRS-AKI (Angeli et al., J Hepatol 2015, revisão 2024); EASL Clinical Practice Guidelines on decompensated cirrhosis, 2018; KDIGO Glomerular Diseases, 2021.

Revisa: UERJ recorrente: SHR x outra causa de lesão renal no cirrótico (nefropatia por IgA)

---

35 Endocrinologia · Tireotoxicose por amiodarona sobre bócio multinodular com Doppler hipervascular e captação baixa: tipo 1, metimazol em dose alta

Rótulo verdadeiro **Gabarito A**

Homem de 67 anos, com miocardiopatia isquêmica (fração de ejeção de 35%) e taquicardia ventricular recorrente, usa amiodarona 200 mg ao dia há 14 meses, além de carvedilol, sacubitril-valsartana e espironolactona. Há 4 anos, ainda sem amiodarona, uma ultrassonografia mostrara bócio multinodular, com punções benignas e TSH normal. Há 5 semanas, perdeu 4 kg, a dispneia piorou e o cardiodesfibrilador deu dois choques apropriados. FC 104 bpm, PA 112 × 70 mmHg. TSH abaixo de 0,01 mUI/L, T4 livre 3,9 ng/dL (0,9 a 1,8), T3 total 260 ng/dL (80 a 200), TRAb negativo. Ultrassonografia com Doppler: tireoide aumentada, multinodular, com vascularização aumentada nos nódulos e no parênquima. Captação de iodo radioativo em 24 horas de 9%. O cardiologista não considera seguro retirar a amiodarona. O tratamento inicial mais adequado da tireotoxicose é:

O DADO QUE DECIDE
com vascularização aumentada nos nódulos e no parênquima

Resolução. A captação baixa e o TRAb negativo parecem indicar tireoidite destrutiva (tipo 2), cujo tratamento é a prednisona. Mas na tireotoxicose por amiodarona a captação é baixa nos dois tipos, porque a carga de iodo da droga dilui o radiotraçador, e por isso ela não separa os tipos. O que separa é a glândula de base e o Doppler: bócio multinodular prévio e vascularização aumentada indicam síntese excessiva de hormônio pelo excesso de iodo em tecido autônomo (tipo 1), enquanto o tipo 2 ocorre em glândula normal com fluxo ausente. O tipo 1 se trata com tionamida em dose alta, eventualmente com perclorato, e a tireoidectomia fica para refratariedade ou para controle rápido em cardiopata grave. A amiodarona pode ser mantida quando é essencial, como aqui.

A) Metimazol em dose alta CORRETA
Correta. Bócio multinodular prévio e hipervascularização ao Doppler definem o tipo 1, de síntese aumentada, tratado com tionamida em dose alta.

B) Suspensão da amiodarona isolada

Errada. Seria aceitável num tipo 2 leve em paciente sem arritmia grave; aqui a droga é essencial e seu efeito persiste por meses após a retirada.

C) Iodo radioativo em dose ablativa

Errada. Seria opção no bócio multinodular tóxico sem carga de iodo; com captação de 9% o iodo radioativo não se concentra na glândula.

D) Prednisona em dose moderada ARMADILHA

Errada. É a armadilha da captação baixa: prednisona é o tratamento do tipo 2, em glândula normal com fluxo ausente, e a captação é baixa nos dois tipos.

Para levar. Na tireotoxicose por amiodarona a captação é baixa nos dois tipos: quem separa é a glândula de base e o Doppler (fluxo aumentado em bócio nodular é tipo 1 e pede tionamida; fluxo ausente em glândula normal é tipo 2 e pede corticoide).

Bartalena L et al. 2018 European Thyroid Association guidelines for the management of amiodarone-associated thyroid dysfunction. Eur Thyroid J 2018; Ross DS et al. 2016 ATA Guidelines for Hyperthyroidism and Other Causes of Thyrotoxicosis. Thyroid 2016.

Revisa: UERJ recorrente: amiodarona e tireoide + S2 q22 (inverteu tipo 1 e tipo 2): agora o tipo 1 com captação baixa como distrator

---

36 Cardiologia · Ruflar apical na insuficiência aórtica grave de valva bicúspide com história reumática: sopro de Austin Flint, que diminui com nitrito de amila

Rótulo verdadeiro **Gabarito C**

Homem de 47 anos sabe ter valva aórtica bicúspide desde o serviço militar. A mãe conta que ele teve febre reumática aos 9 anos, com artrite migratória, e recebeu penicilina benzatina por alguns anos. Há 1 ano tem dispneia aos esforços moderados e palpitações ao deitar sobre o lado esquerdo. Ao exame: PA 158 × 46 mmHg, FC 74 bpm, pulsos amplos e de colapso rápido, oscilação da cabeça a cada batimento; ictus no 7º espaço intercostal, hiperdinâmico. Clique ejetivo, sopro diastólico aspirativo 3+/6 na borda esternal esquerda, com o paciente sentado e inclinado para a frente, e ruflar mesodiastólico 2+/6 no ápice, sem reforço pré-sistólico; B1 normofonética, sem estalido de abertura. Ecocardiograma: insuficiência aórtica grave por valva bicúspide, ventrículo esquerdo com diâmetro sistólico de 48 mm e FE de 56%, valva mitral de folhetos finos e sem fusão comissural. Durante a inalação de nitrito de amila, espera-se que o ruflar apical:

O DADO QUE DECIDE

B1 normofonética, sem estalido de abertura

Resolução. A febre reumática na infância é verdadeira e transforma o ruflar apical em estenose mitral reumática associada, cujo sopro aumenta com o nitrito de amila, porque a vasodilatação provoca taquicardia reflexa e mais fluxo pela valva estreita. Mas a estenose mitral teria B1 hiperfonética e estalido de abertura, e aqui a B1 é normal, não há estalido e o eco mostra folhetos finos sem fusão comissural. O ruflar é o sopro de Austin Flint: o jato regurgitante aórtico grave atinge o folheto anterior da mitral e limita sua abertura, criando uma estenose funcional. Como depende do volume regurgitante, o sopro diminui quando a pós-carga cai, o que o nitrito de amila faz, e aumenta com a preensão palmar sustentada, que eleva a pós-carga. A lesão aórtica é da valva bicúspide (o clique ejetivo a denuncia), e o diâmetro sistólico de 48 mm já se aproxima do limiar cirúrgico de 50 mm.

A) Aumente na inspiração profunda

Errada. Aumento na inspiração (Rivero-Carvallo) é dos sopros de câmaras direitas, como a estenose tricúspide; o ruflar aqui é de origem esquerda.

B) Aumente na fase de esforço do Valsalva

Errada. Aumentar no esforço do Valsalva é comportamento da cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva; quase todos os outros sopros diminuem na manobra.

C) Diminua de intensidade CORRETA

Correta. Austin Flint depende do volume regurgitante aórtico; queda da pós-carga com nitrito de amila reduz o refluxo e o ruflar.

D) Aumente de intensidade ARMADILHA

Errada. É a resposta da estenose mitral reumática, sugerida pela história de febre reumática; B1 normal, ausência de estalido e folhetos finos a afastam.

Para levar. Ruflar apical na insuficiência aórtica grave, com B1 normal e sem estalido, é Austin Flint: diminui com nitrito de amila e aumenta com preensão palmar, ao contrário da estenose mitral, que aumenta com o nitrito.

2020 ACC/AHA Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease; Braunwald's Heart Disease, 12ª ed. (2022), cap. Aortic Regurgitation e Physical Examination of the Heart.

Revisa: UERJ recorrente: sopros e manobras, valva bicúspide e IA com sinais periféricos + S4 q65 (achado esperado)

37

Oncologia · Rastreamento de câncer de pulmão no ex-tabagista pesado com DPOC e pai acometido: pela USPSTF, quem parou há mais de 15 anos não entra

Qualificador **Gabarito D**

Homem de 64 anos procura a unidade de saúde pedindo um exame para câncer de pulmão, porque um amigo da mesma idade acabou de receber esse diagnóstico. Fumou 2 maços por dia dos 18 aos 47 anos (58 maços-ano) e parou há 17 anos, sem recaída. Tem DPOC GOLD 2 em uso de tiotrópio, sem exacerbações no último ano, e o pai morreu de câncer de pulmão aos 70 anos. Nega tosse nova, hemoptise, perda de peso ou dor torácica; a dispneia aos grandes esforços é a mesma de anos. Exame: IMC 27 kg/m², FR 16 irpm, SatO2 95% em ar ambiente, murmúrio vesicular difusamente diminuído, sem baqueteamento digital nem linfonodos palpáveis. Radiografia de tórax de 1 ano atrás com hiperinsuflação, sem nódulos. Segundo a recomendação da USPSTF (2021), a conduta mais adequada quanto ao rastreamento do câncer de pulmão é:

> O DADO QUE DECIDE
>
> *parou há 17 anos*

Resolução. Carga tabágica enorme, DPOC, pai com câncer de pulmão e a idade dentro da faixa fazem a TC de baixa dose anual parecer óbvia. A USPSTF (2021) indica o rastreamento entre 50 e 80 anos para quem tem 20 maços-ano ou mais e fuma atualmente ou parou há no máximo 15 anos; ele parou há 17, e o rastreamento se encerra 15 anos após a cessação. DPOC e história familiar aumentam o risco, mas não são critérios de entrada nessa recomendação. O qualificador do comando é o que decide: a American Cancer Society (2023) retirou o critério de tempo desde a cessação e o incluiria, e no Brasil não há programa organizado do Ministério da Saúde para câncer de pulmão. Sem sintomas, a investigação não se justifica como diagnóstico, e a radiografia de tórax não reduz mortalidade como rastreamento.

A) TC de baixa dose anual ARMADILHA

Errada. É a armadilha da carga tabágica; seria a conduta se ele tivesse parado há 15 anos ou menos, ou pela American Cancer Society (2023), que não usa o tempo desde a cessação.

B) TC de baixa dose por 3 anos

Errada. Três rodadas foi o desenho do NLST, não uma recomendação; quem é elegível faz TC anual enquanto permanecer elegível.

C) Radiografia de tórax anual

Errada. A radiografia de tórax anual não reduziu mortalidade nos ensaios (PLCO) e não é método de rastreamento em nenhuma diretriz.

D) Não indicar o rastreamento CORRETA

Correta. Pela USPSTF, o rastreamento termina quando a cessação passa de 15 anos, independentemente de DPOC e história familiar.

Para levar. USPSTF 2021: TC de baixa dose anual de 50 a 80 anos, com 20 maços-ano ou mais, fumante atual ou que parou há até 15 anos; a ACS 2023 retirou o limite de tempo desde a cessação, por isso o qualificador do comando decide.

USPSTF, Lung Cancer: Screening (2021); American Cancer Society Lung Cancer Screening Guideline (2023); INCA, Detecção precoce do câncer (2021).

Revisa: S3 q34: quando não rastrear (antes encerrar após histerectomia, agora o critério de cessação do tabagismo)

38

Pneumologia · Padrão de pneumonia intersticial usual sem exposição e com FAN 1:80 isolado: FPI diagnosticada sem biópsia e tratada com antifibrótico

Rótulo verdadeiro

Gabarito D

Homem de 69 anos, ex-tabagista (30 maços-ano), contador aposentado, refere dispneia progressiva e tosse seca há 18 meses. Usa losartana e atorvastatina; nunca usou amiodarona, nitrofurantoína ou metotrexato. Nega pássaros, mofo em casa, edredom ou travesseiro de penas, umidificador e trabalho com poeiras. Nega Raynaud, artrite, rigidez matinal, fraqueza muscular, fissuras nas mãos e disfagia. Ao exame, SpO2 93% em repouso, baqueteamento digital e estertores em velcro nas bases, sem lesões cutâneas. FAN 1:80, padrão nuclear pontilhado fino; fator reumatoide, anti-CCP, anti-Ro, anti-Scl-70 e painel de antissintetases negativos; CPK normal. TC de tórax de alta resolução: reticulação subpleural de predomínio basal com faveolamento subpleural basal com bronquiectasias de tração, sem vidro fosco extenso, sem micronódulos e sem atenuação em mosaico. CVF 68% e DLCO 49% do previsto. A discussão multidisciplinar não identificou causa secundária. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

faveolamento subpleural basal com bronquiectasias de tração

Resolução. O FAN reagente é verdadeiro e puxa para doença intersticial associada a colagenose, tratada com imunossupressor. Mas FAN em título baixo (1:80) aparece em parte da população idosa e, sem autoanticorpo específico nem quadro clínico de doença autoimune, não define colagenose. Com as exposições e as drogas afastadas, a TC com padrão de pneumonia intersticial usual definida (faveolamento basal subpleural com bronquiectasias de tração, sem achados de outro padrão) basta para o diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática na discussão multidisciplinar, sem biópsia. O tratamento é antifibrótico (nintedanibe ou

pirfenidona), que reduz o declínio da CVF. Corticoide com azatioprina aumentou mortalidade e internação na FPI (estudo PANTHER) e não se usa.

A) Biópsia pulmonar cirúrgica
Errada. A biópsia cirúrgica ajuda quando a TC é indeterminada ou sugere outro diagnóstico; com padrão de pneumonia intersticial usual definida e sem causa secundária, o diagnóstico de FPI dispensa biópsia, que tem risco nesse paciente.

B) Micofenolato de mofetila ARMADILHA
Errada. É a armadilha do FAN: micofenolato seria a escolha na doença intersticial de esclerose sistêmica ou de outra colagenose definida; FAN 1:80 isolado, sem anticorpo específico nem clínica, não faz esse diagnóstico.

C) Prednisona, azatioprina e N-acetilcisteína
Errada. Foi a terapia antiga da FPI, abandonada porque aumentou mortalidade e internações no estudo PANTHER.

D) Nintedanibe ou pirfenidona CORRETA
Correta. Padrão de pneumonia intersticial usual definida, sem exposição, droga ou colagenose: FPI, tratada com antifibrótico.

Para levar. TC com pneumonia intersticial usual definida, sem exposição, droga ou colagenose, fecha FPI sem biópsia; FAN em título baixo isolado não muda isso, e o tratamento é antifibrótico, nunca corticoide com azatioprina.

ATS/ERS/JRS/ALAT Idiopathic Pulmonary Fibrosis (an update) and Progressive Pulmonary Fibrosis in Adults, 2022; Diretrizes SBPT para FPI (2020).

Revisa: UERJ recorrente: FPI e antifibrótico após perguntar exposição; cruza com S3 q74 (a anamnese de exposição decide antes do exame invasivo)

39

Reumatologia · Pneumopatia intersticial com fator reumatoide, Raynaud e anti-Jo-1 negativo com FAN citoplasmático: painel ampliado de antissintetase

Rótulo verdadeiro **Gabarito A**

Mulher de 52 anos, não tabagista, apresenta há 5 meses dispneia progressiva, tosse seca e febre baixa intermitente, com artralgia simétrica de punhos e metacarpofalangeanas e fenômeno de Raynaud há 1 ano. Nega fraqueza, disfagia ou lesões em pálpebras. Exame: SpO2 de 91% em ar ambiente, estertores em velcro nas bases, força grau 5 nas cinturas, descamação fissurada nas bordas laterais dos dedos indicadores, sem espessamento cutâneo proximal e sem esclerodactilia. CK 160 U/L (referência: até 170), aldolase normal. Fator reumatoide 48 UI/mL (referência: até 14), anti-CCP não reagente, FAN 1:160 com padrão citoplasmático pontilhado fino denso, anti-Jo-1 não reagente, anti-Ro52 reagente, anti-Scl-70 não solicitado. TC de tórax: vidro fosco e reticulado basal com consolidações periféricas, poupando a região subpleural. O exame com maior rendimento para definir o diagnóstico é:

O DADO QUE DECIDE

FAN 1:160 com padrão citoplasmático pontilhado fino denso

Resolução. Raynaud, pneumopatia e fator reumatoide levam o apressado à esclerose sistêmica ou à artrite reumatoide com pulmão, e o anti-Jo-1 negativo com CK normal parece afastar miosite. O conjunto de pneumopatia intersticial com padrão de pneumonia intersticial não específica e organização, artrite, Raynaud,

febre e descamação fissurada nas bordas dos dedos (mãos de mecânico) é a síndrome antissintetase, que frequentemente cursa sem fraqueza e com CK normal, sobretudo com anti-PL-7 e anti-PL-12. O FAN de padrão citoplasmático pontilhado fino denso é o rastro dos anticorpos contra aminoacil-tRNA sintetases, e o anti-Ro52 acompanha esses anticorpos com frequência. O anti-Jo-1 é só um dos oito antissintetase; negativo, pede o painel ampliado (PL-7, PL-12, EJ, OJ), que define o diagnóstico sem procedimento invasivo. Sem esclerodactilia, sem espessamento proximal, o rastreio de esclerose sistêmica rende pouco.

A) Painel ampliado de anticorpos antissintetase CORRETA
Correta. FAN citoplasmático, mãos de mecânico, artrite e pneumopatia com anti-Jo-1 negativo pedem anti-PL-7, anti-PL-12 e os demais antissintetase.

B) Biópsia de quadríceps guiada por ressonância
Errada. Seria útil na miosite com fraqueza e CK alta; aqui a força é normal, a CK também, e o rendimento da biópsia muscular é baixo.

C) Anti-Scl-70 e anticentrômero ARMADILHA
Errada. É a armadilha do Raynaud com pneumopatia: seriam os anticorpos da esclerose sistêmica, que pediria esclerodactilia ou espessamento cutâneo, ausentes, e não explica o FAN citoplasmático.

D) Biópsia pulmonar cirúrgica
Errada. Seria considerada na pneumopatia intersticial sem pista sistêmica; aqui a sorologia dirigida define o diagnóstico sem cirurgia.

Para levar. Pneumopatia intersticial com mãos de mecânico, artrite e FAN citoplasmático é síndrome antissintetase mesmo com anti-Jo-1 negativo e CK normal: peça o painel ampliado (PL-7, PL-12).

Connors GR et al. Interstitial lung disease associated with the idiopathic inflammatory myopathies, Chest 2010; Damoiseaux J et al. International Consensus on ANA Patterns (ICAP), AC-20, 2019; Lundberg IE et al. 2017 EULAR/ACR classification criteria for idiopathic inflammatory myopathies.

Revisa: S3 q27: antissintetase com FR e Raynaud lida como esclerose sistêmica; agora o rótulo é o anti-Jo-1 negativo e a CK normal

---

40 Nefrologia · Lesão renal assintomática no idoso em omeprazol há 10 semanas, sem febre, exantema nem eosinofilia: nefrite intersticial aguda

Negativo no meio | Gabarito A

Homem de 71 anos, com creatinina de 1,0 mg/dL há 6 meses, faz uso de omeprazol 40 mg/dia, iniciado há 10 semanas por dispepsia, além de losartana e atorvastatina há anos. É encaminhado por creatinina de 3,4 mg/dL em exame de rotina; está assintomático. Nega febre, exantema, artralgia, contraste recente e anti-inflamatórios. PA 132 × 80 mmHg, sem edema, mucosas úmidas, sem hipotensão postural. Hemograma com 210 eosinófilos/mm³. Urina: densidade 1,010, proteína 1+, 25 leucócitos e 3 hemácias por campo, cilindros leucocitários; urocultura negativa. Proteinúria de 24 horas de 0,6 g, fração de excreção de sódio de 2,8%, complemento normal e ANCA negativo. Ultrassonografia com rins de 11 cm, sem hidronefrose. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE
cilindros leucocitários; urocultura negativa

Resolução. A ausência de febre, exantema e eosinofilia afasta, para muitos, a nefrite intersticial, e a fração de excreção de sódio acima de 2% leva para necrose tubular. Mas a tríade é exceção, sobretudo nas formas por

inibidor de bomba de prótons, que são insidiosas, em idosos, e muitas vezes descobertas em exame de rotina semanas a meses após o início da droga. Não há evento isquêmico, hipotensão ou nefrotóxico para justificar necrose tubular, e a urina não mostra cilindros granulosos; mostra leucocitúria estéril com cilindros leucocitários, que localizam a inflamação no interstício. A fração de excreção de sódio alta é compatível com lesão tubulointersticial e só exclui a causa pré-renal. A conduta é suspender o omeprazol e considerar corticoide se não houver melhora em poucos dias, com biópsia quando houver dúvida.

A) Nefrite intersticial aguda CORRETA
Correta. Lesão renal semanas após inibidor de bomba de prótons, com leucocitúria estéril, cilindros leucocitários e proteinúria baixa, é nefrite intersticial aguda mesmo sem a tríade.

B) Necrose tubular aguda isquêmica ARMADILHA
Errada. É a armadilha da fração de excreção de sódio: a necrose tubular exigiria insulto isquêmico ou tóxico e daria cilindros granulosos, e não leucocitários.

C) Pielonefrite aguda bilateral
Errada. Pielonefrite também dá cilindros leucocitários, mas com febre, dor lombar e urocultura positiva; aqui a urocultura é negativa e o paciente está afebril.

D) Lesão pré-renal pela losartana
Errada. A losartana é usada há anos, a volemia está normal e a fração de excreção de sódio de 2,8% exclui lesão pré-renal.

Para levar. Nefrite intersticial por inibidor de bomba de prótons costuma vir sem febre, exantema ou eosinofilia; leucocitúria estéril com cilindros leucocitários e droga nova bastam para a hipótese.

KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury; Moledina DG, Perazella MA. Drug-induced acute interstitial nephritis. Clin J Am Soc Nephrol 2017.

Revisa: UERJ recorrente: NIA por droga; padrão do aluno de descartar diagnóstico pela ausência de achado (S3 q66)

---

41 Infectologia · Pneumonia por Mycoplasma com crioaglutinina em usuária de metadona com QT longo: doxiciclina, e não macrolídeo

Droga a deduzir **Gabarito A**

Mulher de 24 anos, estudante, procura a emergência por tosse seca há 9 dias, cefaleia, dor de garganta, otalgia direita e febre baixa; o irmão, com quem divide o quarto, teve quadro semelhante há 3 semanas. Está em programa de substituição com metadona 110 mg/dia há 1 ano, sem uso de outras substâncias; não tem alergias. Ao exame, temperatura 37,8 °C, FR 20 irpm, SpO2 95% em ar ambiente, PA 118/72 mmHg, estertores finos nas bases e vesículas hemorrágicas na membrana timpânica direita. Radiografia: infiltrado reticular bilateral nas bases. Hemoglobina 10,1 g/dL, reticulócitos 6%, bilirrubina indireta 2,4 mg/dL, LDH 520 U/L; teste de antiglobulina direto positivo para C3d e negativo para IgG. Ureia e creatinina normais; beta-hCG negativo. Eletrocardiograma: ritmo sinusal, QTc de 512 ms. Será tratada em domicílio. O antimicrobiano isolado mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE
QTc de 512 ms

Resolução. Tosse seca arrastada em adulto jovem, contato domiciliar com quadro igual, miringite bolhosa, infiltrado intersticial e anemia hemolítica por crioaglutinina (C3d positivo, IgG negativo) apontam Mycoplasma

pneumoniae, e o macrolídeo é a escolha de rotina. O detalhe está na droga em uso: a metadona em dose alta prolonga o QT, e o eletrocardiograma já mostra QTc acima de 500 ms, faixa em que acrescentar outra droga que prolonga o QT aumenta o risco de torsades de pointes. Azitromicina e levofloxacino prolongam o QT e ficam contraindicados. A doxiciclina cobre Mycoplasma, não tem esse efeito e serve à paciente não gestante. Amoxicilina não age sobre um agente sem parede celular.

A) Doxiciclina CORRETA
Correta. Cobre Mycoplasma sem prolongar o QT, e a beta-hCG negativa libera seu uso.

B) Azitromicina ARMADILHA
Errada. É a armadilha do agente: seria a escolha se o QTc fosse normal, mas prolonga o QT em quem já está acima de 500 ms com metadona.

C) Levofloxacino
Errada. Cobre Mycoplasma e seria alternativa em quem não tolera macrolídeo e tetraciclina, mas também prolonga o QT.

D) Amoxicilina
Errada. Seria a escolha na pneumonia pneumocócica de baixo risco; Mycoplasma não tem parede celular e não responde a betalactâmico.

Para levar. O agente escolhe a classe, e o paciente escolhe a droga: Mycoplasma com QTc acima de 500 ms (metadona, antiarrítmico, QT longo congênito) se trata com doxiciclina.

Diretrizes Brasileiras para Pneumonia Adquirida na Comunidade em Adultos Imunocompetentes, SBPT (2018); ATS/IDSA Community-Acquired Pneumonia Guideline (2019); CredibleMeds QT drug lists (2025).

Revisa: S2 q51: Mycoplasma com crioaglutinina, agora a armadilha é o próprio macrolídeo correto contra o agente

---

42 Hematologia · Hematoma espontâneo no idoso com TTPa isolado longo que corrige na mistura imediata e volta a prolongar após incubação: hemofilia A adquirida e agente de bypass

Grade X / Y **Gabarito B**

Homem de 74 anos, diabético e hipertenso, em uso de metformina, losartana e AAS 100 mg/dia, procura a emergência por aumento de volume doloroso na coxa direita há 4 dias, sem trauma, e equimoses extensas nos braços há 2 semanas. Nunca sangrou de forma anormal: fez herniorrafia aos 60 anos e três extrações dentárias sem intercorrência. Sem hepatopatia e sem história familiar de sangramento. Exame: FC 108 bpm, PA 112 × 70 mmHg, coxa direita tensa, com equimose que se estende ao joelho, pulsos distais presentes. Exames: Hb 7,6 g/dL (era 13,1 há 3 meses), plaquetas 236.000/mm³, TP com INR 1,0, fibrinogênio 390 mg/dL, TTPa 81 s (controle 30 s). No teste da mistura com plasma normal (1:1), o TTPa cai para 33 s na leitura imediata e, após incubação por 2 horas a 37 °C, sobe para 62 s. Fator VIII 2%, fator IX 96%, fator XI 88%. Quanto ao diagnóstico e ao tratamento hemostático, a conduta mais adequada é, respectivamente:

> O DADO QUE DECIDE
> *após incubação por 2 horas a 37 °C, sobe para 62 s*

Resolução. O TTPa que corrige na leitura imediata da mistura é o achado tranquilizador que puxa para deficiência de fator, e um fator VIII de 2% parece fechar hemofilia A a ser reposta com fator VIII. Dois dados derrubam essa leitura. A história hemostática é limpa até os 74 anos, com cirurgia e extrações sem

sangramento, o que não combina com fator VIII de 2% congênito. E a mistura que volta a prolongar depois de 2 horas a 37 °C indica inibidor tempo e temperatura dependente, comportamento dos autoanticorpos contra o fator VIII, que neutralizam o fator do plasma normal lentamente. Hemofilia A adquirida, no idoso, se apresenta com hematomas musculares e equimoses extensas, e sangra mais que a congênita. O concentrado de fator VIII é neutralizado pelo inibidor; o tratamento do sangramento é com agente de bypass (fator VII ativado recombinante ou complexo protrombínico ativado), ou fator VIII porcino recombinante, junto com imunossupressão (prednisona, com ou sem ciclofosfamida ou rituximabe) para erradicar o inibidor, dosado pelo método Bethesda. O AAS deve ser suspenso, e procedimentos invasivos evitados.

A) Hemofilia A leve congênita / fator VII ativado recombinante
Errada. O agente de bypass é o tratamento certo, mas o diagnóstico não: hemofilia congênita com 2% de fator VIII teria sangrado nas cirurgias anteriores, e a mistura não voltaria a prolongar.

B) Hemofilia A adquirida / fator VII ativado recombinante CORRETA
Correta. Fator VIII baixo, história hemostática prévia normal e mistura que prolonga após incubação definem o inibidor adquirido; o sangramento se trata contornando o fator VIII.

C) Hemofilia A leve congênita / concentrado de fator VIII ARMADILHA
Errada. É a armadilha da correção imediata: seria a conduta numa hemofilia congênita sem inibidor, mas aqui o anticorpo neutralizaria o concentrado de fator VIII infundido.

D) Hemofilia A adquirida / concentrado de fator VIII
Errada. O diagnóstico está certo, mas o fator VIII humano em dose padrão é inativado pelo autoanticorpo; só tem papel em altas doses com inibidor de título muito baixo, e não como primeira escolha no sangramento grave.

Para levar. TTPa isolado longo em idoso sem passado de sangramento, com mistura que corrige e depois prolonga após incubação, é hemofilia A adquirida: agente de bypass para sangrar menos e imunossupressão para tirar o inibidor.

Tiede A et al. International recommendations on the diagnosis and treatment of acquired hemophilia A. Haematologica 2020; Manual de diagnóstico e tratamento de coagulopatias hereditárias e adquiridas, Ministério da Saúde.

Revisa: UERJ recorrente: hemofilia A adquirida e o teste da mistura com incubação, separando do déficit congênito

---

43

Neurologia · Encaminhado como ELA, com Lhermitte, urgência miccional e desnervação restrita a C5 a C7: mielopatia cervical que se opera

Rótulo verdadeiro **Gabarito D**

Homem de 61 anos, pedreiro aposentado, diabético em uso de metformina, é encaminhado com hipótese de esclerose lateral amiotrófica por fraqueza e atrofia das mãos e dos braços há 10 meses, fasciculações em bíceps e deltoides e marcha 'dura', com duas quedas no último mês. Relata choque que desce pela coluna ao fletir o pescoço e urgência miccional recente. Exame: atrofia de interósseos e de bíceps bilateral, reflexos bicipitais abolidos e tricipitais vivos, sinal de Hoffmann bilateral, hiper-reflexia patelar e Babinski bilateral; vibração abolida nos tornozelos; língua sem atrofia nem fasciculações, fala e deglutição normais. B12 450 pg/mL, HbA1c 7,0%. RM cervical: estenose de C4 a C6 com hipersinal medular em T2 em C5. ENMG: desnervação ativa e crônica restrita aos miótomos de C5 a C7, com língua, paravertebrais torácicos e membros inferiores sem desnervação. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

restrita aos miótomos de C5 a C7

Resolução. Fasciculações, atrofia e sinais piramidais juntos no encaminhamento levam à ELA e ao riluzol. Mas a combinação de neurônio motor inferior e superior também aparece na mielopatia cervical: a compressão das raízes e do corno anterior em C5 a C7 dá atrofia, fasciculação e arreflexia bicipital, e a compressão medular abaixo dá Hoffmann, hiper-reflexia e Babinski. O que decide é a distribuição: a desnervação está restrita aos segmentos comprimidos, e bulbo, região torácica e membros inferiores estão poupados, o que afasta a ELA, que exige achados em segmentos que a compressão não alcança. Além disso, há Lhermitte, urgência miccional e perda de vibração, que a ELA não produz (a neuropatia diabética pode explicar a vibração, mas não o resto). Mielopatia moderada a grave, progressiva e com quedas, tem indicação de descompressão.

A) Riluzol e acompanhamento multiprofissional ARMADILHA
Errada. Seria a conduta na ELA, com desnervação em segmentos fora da compressão, como língua ou paravertebrais torácicos, aqui normais.

B) Colar cervical e fisioterapia por 3 meses
Errada. Tratamento conservador cabe na mielopatia leve e estável; quedas, urgência miccional e piora em 10 meses indicam cirurgia.

C) Repetir a eletroneuromiografia em 6 meses
Errada. Seria razoável se o diagnóstico fosse duvidoso, mas sinais sensitivos e esfincterianos com desnervação restrita aos segmentos comprimidos já definem a mielopatia.

D) Descompressão cirúrgica cervical CORRETA
Correta. Desnervação limitada aos miótomos comprimidos, Lhermitte e urgência miccional caracterizam mielopatia cervical moderada a grave e progressiva.

Para levar. Na dúvida entre ELA e mielopatia cervical, a pergunta é se há desnervação fora dos segmentos comprimidos (bulbo, tórax, pernas) e se há sinais sensitivos ou esfincterianos: desnervação restrita e sintomas sensitivos são mielopatia, que se opera quando progride.

Fehlings MG et al. AO Spine/CSRS Clinical Practice Guideline for the Management of Degenerative Cervical Myelopathy, Global Spine J 2017; Shefner JM et al. Gold Coast criteria for ALS, Clin Neurophysiol 2020.

Revisa: S1 q34 e S4 q1: a regra ELA x mielopatia aplicada no sentido inverso, quando a mielopatia é real e a ELA é o rótulo

---

44 Cardiologia · Fibrilação atrial paroxística em coração estruturalmente normal na mulher sem outros fatores: propafenona e sem anticoagulação

Grade X / Y **Gabarito D**

Mulher de 52 anos tem fibrilação atrial paroxística diagnosticada há 8 meses, com três crises sintomáticas desde então, a última de 30 horas, revertida na emergência com medicação venosa. Usa metoprolol 50 mg de 12 em 12 horas, sem efeitos adversos, e continua com palpitações que a afastaram do trabalho. Não tem hipertensão, diabetes, doença vascular ou insuficiência cardíaca; a mãe teve AVC aos 81 anos. Bebe uma taça de vinho nos fins de semana. Ao exame: PA 122 × 76 mmHg, FC 64 bpm, ritmo regular, sem sopros. TSH 1,8 mUI/L, função renal e hepática normais. Ecocardiograma: FE de 64%, septo e parede posterior de 9 mm, átrio esquerdo de 37 mm, valvas normais. Teste ergométrico máximo sem isquemia. Ela prefere tratamento

medicamentoso a ablação neste momento. Para prevenir novas crises e quanto à anticoagulação, a conduta mais adequada é, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

FE de 64%, septo e parede posterior de 9 mm

Resolução. O sexo feminino somava um ponto no antigo CHA2DS2-VASc, e a crise longa de 30 horas e o AVC da mãe parecem reforçar a necessidade de anticoagular; essa é a isca. Mas o sexo isolado nunca indicou anticoagulação (era modificador de risco, não fator), e a diretriz europeia de 2024 o retirou do escore (CHA2DS2-VA): esta paciente tem zero, a duração da crise não entra no cálculo e a história familiar também não. Para o controle do ritmo, o dado que decide é o coração estruturalmente normal: FE preservada, sem hipertrofia significativa e sem isquemia ao teste máximo. Nesse cenário, os antiarrítmicos da classe IC (propafenona, flecainida) são de primeira linha, eficazes e sem a toxicidade de órgão da amiodarona, que fica para cardiopatia estrutural ou insuficiência cardíaca. O betabloqueador que ela já usa deve ser mantido, porque bloqueia o nó atrioventricular e evita o flutter com condução 1:1 que a classe IC pode provocar. A ablação por cateter continua sendo opção de primeira linha se ela mudar de ideia.

A) Amiodarona / apixabana
Errada. Seria a combinação de um paciente com cardiopatia estrutural e escore de pelo menos 2; ela não tem nenhum dos dois.

B) Amiodarona / sem anticoagulação
Errada. A ausência de anticoagulação está certa, mas amiodarona não é a primeira escolha em coração normal, pela toxicidade tireoidiana, pulmonar e hepática a longo prazo.

C) Propafenona / apixabana ARMADILHA
Errada. É a armadilha do sexo feminino; mulher sem outro fator tem CHA2DS2-VA zero e não se beneficia de anticoagular.

D) Propafenona / sem anticoagulação CORRETA
Correta. Coração estruturalmente normal permite classe IC, mantida com o betabloqueador, e o escore zero dispensa anticoagulação.

Para levar. Fibrilação atrial em coração estruturalmente normal (sem cardiopatia isquêmica, sem disfunção e sem hipertrofia importante): propafenona ou flecainida associada a bloqueador nodal. Sexo feminino sozinho não indica anticoagulação, e a duração da crise não entra no escore.

2024 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation; 2023 ACC/AHA/ACCP/HRS Guideline for the Diagnosis and Management of Atrial Fibrillation; Diretriz Brasileira de Fibrilação Atrial, SBC.

Revisa: UERJ recorrente: antiarrítmico em coração normal e anticoagulação na FA + S4 q56 (decisão de anticoagulante por critério)

---

45 Reumatologia · Síndrome nefrótica em artrite reumatoide antiga e mal controlada, em uso de naproxeno: amiloidose AA, e não lesão mínima por anti-inflamatório

Rótulo verdadeiro | Gabarito D

Homem de 61 anos, com artrite reumatoide soropositiva e erosiva há 19 anos, tratada de forma irregular, usa naproxeno 500 mg duas vezes ao dia há anos e prednisona 7,5 mg/dia. A PCR se manteve entre 40 e 80 mg/L

em todas as dosagens dos últimos 5 anos. Há 3 meses, edema progressivo de membros inferiores e diarreia crônica sem sangue. PA 112 × 70 mmHg, edema até a raiz das coxas, fígado palpável a 3 cm do rebordo costal. Albumina 2,1 g/dL, proteinúria de 9,6 g/24 h, sedimento urinário sem hematúria e sem leucocitúria, creatinina 1,6 mg/dL, C3 e C4 normais, FAN não reagente. Eletroforese de proteínas sem pico monoclonal, imunofixação negativa e relação kappa/lambda de cadeias leves livres normal. Ultrassonografia: rins de 12,8 e 13,1 cm, com ecogenicidade aumentada. Na biópsia renal, o achado esperado é:

O DADO QUE DECIDE

A PCR se manteve entre 40 e 80 mg/L em todas as dosagens dos últimos 5 anos

Resolução. O uso crônico de naproxeno é verdadeiro e puxa para doença de lesões mínimas por anti-inflamatório, que é causa conhecida de síndrome nefrótica. O dado que decide é a inflamação crônica não controlada: PCR persistentemente alta por anos em artrite reumatoide antiga mantém a produção hepática de proteína amiloide A sérica, cujo fragmento se deposita como amiloide AA. O quadro acompanha: proteinúria nefrótica com sedimento inerte, rins de tamanho normal a aumentado apesar da creatinina alta, hepatomegalia e diarreia por acometimento intestinal. A lesão mínima por anti-inflamatório costuma vir com nefrite intersticial (leucocitúria) e não explica fígado nem intestino. A imunofixação e a relação de cadeias leves normais afastam a amiloidose AL. A biópsia mostra material amorfo com birrefringência verde-maçã ao vermelho Congo sob luz polarizada, com imuno-histoquímica positiva para proteína AA; o tratamento é controlar a inflamação de base.

A) Fusão difusa de podócitos sem depósitos ARMADILHA
Errada. Seria o achado da lesão mínima induzida por anti-inflamatório, sugerida pelo naproxeno; não explica hepatomegalia, diarreia e rins aumentados com inflamação crônica de anos.

B) Depósitos subepiteliais com espículas na prata
Errada. Seria a nefropatia membranosa, ligada no passado a sais de ouro e penicilamina, ausentes, e que não cursa com hepatomegalia nem diarreia.

C) Depósitos mesangiais dominantes de IgA
Errada. A nefropatia por IgA pode acompanhar doenças inflamatórias, mas cursaria com hematúria, e o sedimento aqui é inerte.

D) Depósitos amorfos com birrefringência verde-maçã CORRETA
Correta. Inflamação crônica não controlada por anos, nefrótica com sedimento inerte, rins aumentados, fígado e intestino acometidos e sem clone de plasmócitos indicam amiloidose AA.

Para levar. Síndrome nefrótica com sedimento inerte e rins grandes em doença inflamatória crônica mal controlada é amiloidose AA até prova em contrário; o anti-inflamatório em uso não muda isso, e o tratamento é controlar a inflamação.

Papa R, Lachmann HJ. Secondary, AA, amyloidosis, Rheum Dis Clin North Am 2018; KDIGO 2021 Clinical Practice Guideline for the Management of Glomerular Diseases.

Revisa: UERJ recorrente: amiloidose AA na doença inflamatória crônica; padrão do aluno de aceitar a droga em uso como causa (rótulo verdadeiro)

46

Endocrinologia · Hipotireoidismo franco em bipolar estável com lítio após falha de outros estabilizadores, com sintomas depressivos atribuídos à

Rótulo verdadeiro | Gabarito A

droga: levotiroxina mantendo o lítio

Mulher de 46 anos, com transtorno bipolar tipo I, está estável há 5 anos com carbonato de lítio 900 mg ao dia (litemia 0,8 mEq/L), introduzido após falha prévia com valproato e com lamotrigina. Há 4 meses refere cansaço, ganho de 5 kg, constipação, pele seca e desânimo, e a família teme uma nova fase depressiva. Nega mudança de dose, diuréticos ou anti-inflamatórios. PA 128 × 84 mmHg, FC 58 bpm, tireoide discretamente aumentada, difusa, indolor, reflexos com relaxamento lentificado. TSH 11,8 mUI/L (0,4 a 4,5), T4 livre 0,7 ng/dL (0,9 a 1,8), anti-TPO positivo, cálcio 9,6 mg/dL, sódio 139 mEq/L, creatinina 0,9 mg/dL. O residente de psiquiatria, lembrando que o lítio é bociogênico, propõe trocá-lo. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

introduzido após falha prévia com valproato e com lamotrigina

Resolução. O lítio é concentrado pela tireoide e inibe a liberação de T4 e T3, e o hipotireoidismo é seu efeito endócrino mais frequente, sobretudo em mulheres com anti-TPO positivo. A atribuição à droga é verdadeira e leva à ideia de trocá-la, mas o hipotireoidismo pelo lítio não é indicação de suspendê-lo: trata-se com levotiroxina e o lítio continua, ainda mais numa paciente estável há 5 anos que já falhou com os estabilizadores alternativos. Aqui o hipotireoidismo é franco (TSH alto com T4 livre baixo, bradicardia e reflexos lentos), então não cabe apenas repetir os exames, e reduzir a dose do lítio arrisca recaída sem corrigir a tireoide. O desânimo e o cansaço podem ser do próprio hipotireoidismo, que também favorece depressão e ciclagem rápida no transtorno bipolar, e melhoram com a reposição.

A) Levotiroxina, mantendo o lítio CORRETA
Correta. Hipotireoidismo franco pelo lítio se trata com levotiroxina, e o lítio eficaz é mantido, sobretudo após falha de outros estabilizadores.

B) Repetir TSH e T4 livre em 8 semanas
Errada. Repetir antes de tratar seria adequado no hipotireoidismo subclínico com TSH abaixo de 10; aqui o T4 livre já é baixo e há sinais clínicos.

C) Reduzir o lítio e repetir o TSH
Errada. Seria uma tentativa diante de toxicidade dose-dependente, como tremor com litemia alta; a litemia é terapêutica e reduzir a dose arrisca recaída sem tratar a tireoide.

D) Trocar o lítio por valproato ARMADILHA
Errada. É a armadilha do rótulo verdadeiro: a causa é o lítio, mas isso não obriga a trocá-lo, e a paciente já falhou com valproato.

Para levar. Hipotireoidismo pelo lítio se trata com levotiroxina e não obriga a suspender o lítio; o mesmo vale para o hiperparatireoidismo e o diabetes insípido nefrogênico, que têm conduta própria com a droga mantida quando ela é necessária.

Jonklaas J et al. Guidelines for the treatment of hypothyroidism: American Thyroid Association. Thyroid 2014; Lazarus JH. Lithium and thyroid. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2009; CANMAT/ISBD Guidelines for the management of patients with bipolar disorder, 2018.

Revisa: UERJ recorrente: lítio e seus distúrbios hormonais + S1 q10; o hipotireoidismo pelo lítio que não obriga a trocar a droga

47

Rótulo verdadeiro

Gabarito B

Nefrologia · Alcalose hipocalêmica com sódio urinário alto e cloro urinário baixo: vômitos autoinduzidos, e não diurético oculto

Mulher de 23 anos, estudante de nutrição, é levada pela mãe por fraqueza e palpitações há 1 semana. Diz que segue dieta restritiva por conta própria e nega vômitos, laxantes e diuréticos. IMC 18,9 kg/m², PA 100 × 62 mmHg, FC 104 bpm. Hipertrofia bilateral de parótidas e erosão do esmalte nas faces palatinas dos incisivos; sem lesões no dorso das mãos. Exames: Na 137 mEq/L, K 2,6 mEq/L, Cl 88 mEq/L, HCO3 34 mEq/L, pH 7,51, Mg 2,0 mg/dL, creatinina 0,8 mg/dL. Urina isolada: Na 72 mEq/L, K 38 mEq/L, Cl 7 mEq/L, pH 7,8. A pesquisa de diuréticos na urina foi solicitada e está pendente. A causa mais provável da hipocalemia é:

O DADO QUE DECIDE

Cl 7 mEq/L, pH 7,8

Resolução. O sódio urinário de 72 mEq/L com potássio urinário alto parece perda renal de sal, e a negativa de vômitos com a pesquisa de diurético pendente empurra para diurético oculto. Na alcalose metabólica, porém, o marcador de volume é o cloro urinário, e não o sódio: nos vômitos recentes, o bicarbonato filtrado em excesso arrasta sódio e potássio para a urina, que fica alcalina (pH 7,8), enquanto o cloro fica muito baixo pela contração de volume. Diurético em uso e Bartter dão cloro urinário alto, junto com o sódio. A hipertrofia de parótidas e a erosão palatina do esmalte confirmam a origem gástrica; a ausência do sinal de Russell não exclui, porque muitas pacientes induzem o vômito sem os dedos. O laxativo daria sódio e cloro urinários baixos e tende a acidose, não a urina alcalina com bicarbonatúria.

A) Abuso de laxativos estimulantes
Errada. O abuso de laxativo conserva sódio e cloro na urina, que não fica alcalina, e com frequência cursa com acidose.

B) Vômitos autoinduzidos CORRETA
Correta. Alcalose com cloro urinário baixo e urina alcalina com sódio alto (bicarbonatúria), parótidas aumentadas e erosão palatina indicam vômitos.

C) Uso oculto de diurético tiazídico ARMADILHA
Errada. É a armadilha do sódio urinário alto: o diurético em uso elevaria também o cloro urinário, que aqui é de 7 mEq/L.

D) Síndrome de Bartter
Errada. Bartter cursa com cloro urinário persistentemente alto e perda de sal desde a infância; aqui o cloro urinário é mínimo.

Para levar. Na alcalose metabólica hipocalêmica, leia o cloro urinário, e não o sódio: cloro baixo com sódio alto e urina alcalina é vômito recente; cloro alto é diurético em uso, Bartter ou Gitelman.

Luke RG, Galla JH. It is chloride depletion alkalosis, not contraction alkalosis. J Am Soc Nephrol 2012; Brenner and Rector's The Kidney, 11ª ed. (2020), cap. Metabolic Alkalosis.

Revisa: UERJ recorrente: bulimia x diurético pela urina + S1 q45 (alcalose hipocalêmica decidida por um exame)

48 Infectologia · Derrame pleural com ADA alto na aids com Kaposi e contato de tuberculose: linfoma primário de efusão pelo imunofenótipo

Rótulo verdadeiro **Gabarito A**

Homem de 38 anos, com diagnóstico de HIV há 2 meses (CD4 de 45 células/mm³), em uso de TARV há 5 semanas, tem placas violáceas nos membros inferiores, cuja biópsia mostrou sarcoma de Kaposi. Há 3 semanas apresenta dispneia progressiva, febre baixa noturna e perda de 4 kg. O irmão, com quem mora, terminou há 4 meses o tratamento de tuberculose pulmonar. Temperatura 37,9 °C, FR 26 irpm, SpO2 91% em ar ambiente, abolição do murmúrio no terço inferior do hemitórax direito. TC de tórax: derrame pleural direito volumoso, sem espessamento pleural nodular, sem massa mediastinal, sem linfonodomegalias e sem lesões parenquimatosas. Toracocentese: exsudato serossanguinolento, LDH 1.450 U/L, proteína 4,8 g/dL, ADA 58 U/L (referência: até 40), teste rápido molecular para tuberculose não detectado. Citologia: grandes células atípicas de aspecto plasmablástico; imunofenotipagem com CD45 e CD138 positivos, CD20 e CD79a negativos, e marcação nuclear para LANA-1 (HHV-8). O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

CD45 e CD138 positivos, CD20 e CD79a negativos

Resolução. O contato domiciliar de tuberculose, a febre noturna, o exsudato e o ADA acima de 40 são verdadeiros e montam a tuberculose pleural, ainda mais com o teste molecular de baixa sensibilidade no líquido pleural. Mas o ADA sobe também em linfomas e empiemas, e a citologia mostrou o que a tuberculose não produz: células neoplásicas grandes, plasmablásticas, em suspensão no líquido, sem massa sólida. O imunofenótipo decide: marcador leucocitário (CD45) e plasmocitário (CD138) positivos, com os marcadores de linhagem B (CD20 e CD79a) negativos, e infecção pelo HHV-8 demonstrada por LANA-1 nas células. Isso é linfoma primário de efusão, que surge na aids avançada, frequentemente ao lado do Kaposi, porque compartilha o mesmo vírus. O Kaposi pleural dá derrame serossanguinolento, mas não células linfoides atípicas flutuantes; o Burkitt expressa CD20 e forma massas, em geral com CD4 mais preservado.

A) Linfoma primário de efusão CORRETA

Correta. Células plasmablásticas em cavidade serosa, sem massa, CD45 e CD138 positivos, CD20 negativo e HHV-8 positivo definem o linfoma primário de efusão.

B) Tuberculose pleural ARMADILHA

Errada. É a armadilha do contato e do ADA alto; seria a certa com exsudato linfocítico de células pequenas, sem células atípicas, mas o ADA também sobe em linfoma.

C) Sarcoma de Kaposi pleural

Errada. Também é HHV-8 e cursa com derrame serossanguinolento, mas a lesão é vascular (células fusiformes) e não lança células linfoides atípicas no líquido.

D) Linfoma de Burkitt

Errada. Seria a certa com massa abdominal, lise tumoral e células B CD20 positivas com MYC rearranjado, e não com fenótipo plasmablástico sem marcadores B.

Para levar. Na aids avançada, derrame cavitário sem massa com células grandes CD20 negativas, CD138 positivas e HHV-8 positivas é linfoma primário de efusão; ADA alto não fecha tuberculose quando a citologia mostra células atípicas.

WHO Classification of Haematolymphoid Tumours, 5ª ed. (2022); NCCN Guidelines: B-Cell Lymphomas, HIV-related lymphomas (2025); Ministério da Saúde, PCDT para Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos (2024).

Revisa: S4 q36 e S1 q37: o linfoma da aids, agora quando a resposta certa é o linfoma de efusão e o rótulo verdadeiro é a tuberculose

---

49

Gastroenterologia e hepatologia · Vesículas pruriginosas em superfícies extensoras com antitransglutaminase alta: imunofluorescência direta da pele perilesional, e não da lesão

Qualificador **Gabarito C**

Homem de 27 anos, há 5 meses com pápulas e vesículas agrupadas, intensamente pruriginosas, simétricas em cotovelos, joelhos, região sacral e couro cabeludo, a maioria escoriada. Usou corticoide tópico de alta potência sem melhora. Nega diarreia, dor abdominal ou perda de peso, e não usa medicações. Tem tireoidite de Hashimoto em levotiroxina. Ao exame, bom estado geral, sem lesões em mucosas, sinal de Nikolsky negativo. Hb 12,1 g/dL, VCM 76 fL, ferritina 9 ng/mL; IgA sérica total normal; antitransglutaminase IgA de 86 U/mL (referência abaixo de 10). Uma biópsia de vesícula íntegra mostrou clivagem subepidérmica com microabscessos de neutrófilos nas papilas dérmicas, laudada como dermatose bolhosa subepidérmica a esclarecer. Para confirmar a natureza da lesão cutânea, o exame mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

Para confirmar a natureza da lesão cutânea

Resolução. A distribuição simétrica em superfícies extensoras, sacro e couro cabeludo, o prurido intenso, a anemia ferropriva e a antitransglutaminase alta compõem dermatite herpetiforme, a manifestação cutânea da doença celíaca. A histologia com microabscessos papilares é compatível, mas não específica, e o que confirma é a imunofluorescência direta mostrando depósitos granulares de IgA nas papilas dérmicas. O detalhe que a banca cobra é o local: a biópsia para imunofluorescência deve ser da pele normal adjacente à lesão, porque na vesícula a inflamação degrada os depósitos e gera falso negativo. Confirmada a dermatite herpetiforme com sorologia positiva, a biópsia duodenal não é necessária para o diagnóstico de doença celíaca, e o tratamento é dieta sem glúten, com dapsona para o controle inicial das lesões.

A) Biópsia duodenal com quatro fragmentos
Errada. Confirmaria enteropatia no celíaco sem lesão cutânea; aqui a pergunta é a lesão de pele, e a imunofluorescência positiva dispensa a biópsia duodenal.

B) Anticorpos séricos anti-BP180 e anti-BP230
Errada. Serviria para penfigoide bolhoso, que acomete idosos, com bolhas tensas e sem relação com antitransglutaminase.

C) Imunofluorescência direta da pele perilesional CORRETA
Correta. A pele perilesional mostra IgA granular nas papilas dérmicas e confirma dermatite herpetiforme.

D) Imunofluorescência direta da vesícula ARMADILHA
Errada. É a armadilha: a imunofluorescência é o exame certo, mas na vesícula a inflamação destrói os depósitos de IgA e dá falso negativo.

Para levar. Na dermatite herpetiforme, a imunofluorescência direta se faz na pele normal ao lado da lesão; com ela positiva e sorologia celíaca alta, não é preciso biópsia duodenal.

British Society of Gastroenterology guidelines on the diagnosis and management of coeliac disease, 2014; Reunala T et al. Dermatitis herpetiformis: an update on diagnosis and management. Am J Clin Dermatol 2021; ACG Clinical Guideline: Celiac Disease, 2023.

Revisa: UERJ recorrente: doença celíaca, aqui pela manifestação cutânea e pelo local da biópsia

---

50 Pneumologia · DPOC recém-diagnosticada, pouco sintomática entre as crises, com duas exacerbações e eosinófilos de 340: terapia tripla inicial (GOLD)

Rótulo verdadeiro **Gabarito C**

Homem de 67 anos, ex-tabagista (45 maços-ano, parou há 2 anos), procura o ambulatório para iniciar tratamento após espirometria solicitada pelo clínico. Nos últimos 12 meses foi duas vezes à UPA por piora da tosse e da dispneia com escarro purulento, tratado com prednisona oral e antibiótico, sem internação. Teve pneumonia tratada ambulatorialmente há 5 anos, sem novos episódios. Entre as crises diz que se sente bem: caminha 3 km por dia, mMRC 1 e CAT 9. Usa apenas anlodipino. Ao exame, FR 16 irpm, SpO2 95% em ar ambiente, murmúrio vesicular discretamente reduzido, sem sibilos. Espirometria pós-broncodilatador: VEF1/CVF 0,58 e VEF1 de 64% do previsto, sem resposta significativa ao broncodilatador. Hemograma colhido fora de exacerbação, sem corticoide há 4 meses: eosinófilos 340/mm³. Radiografia de tórax com hiperinsuflação, sem consolidação. O tratamento inalatório de manutenção mais adequado para iniciar é:

O DADO QUE DECIDE

eosinófilos 340/mm³

Resolução. Os poucos sintomas entre as crises (mMRC 1, CAT 9) e a pneumonia antiga são verdadeiros e empurram para um broncodilatador isolado ou para a dupla broncodilatação, evitando corticoide. Mas o grupo do GOLD se decide pelas exacerbações antes dos sintomas: duas exacerbações moderadas no ano colocam o paciente no grupo E, qualquer que seja o CAT. No grupo E, o ponto de partida é LABA com LAMA, e a terapia tripla já é a escolha inicial quando os eosinófilos estão em 300/mm³ ou mais, como aqui, medidos fora de exacerbação e sem corticoide. Uma pneumonia isolada há 5 anos não é o antecedente de pneumonias repetidas que pesa contra o corticoide inalatório. LABA com corticoide sem LAMA não é mais recomendado na DPOC.

A) LAMA isolado

Errada. Seria a opção do paciente sem exacerbações e com poucos sintomas (grupo A); duas exacerbações com corticoide oral no ano o põem no grupo E.

B) LABA associado a LAMA ARMADILHA

Errada. É a armadilha: seria o início no grupo E com eosinófilos abaixo de 300/mm³; aqui a contagem de 340/mm³ indica a tripla, e a pneumonia única e antiga não a contraindica.

C) LABA, LAMA e corticoide inalatório CORRETA

Correta. Grupo E (duas exacerbações moderadas) com eosinófilos de 340/mm³: LABA, LAMA e corticoide inalatório desde o início.

D) LABA associado a corticoide inalatório

Errada. LABA com corticoide sem LAMA não é mais indicado na DPOC; quando há indicação de corticoide inalatório, a combinação preferida é a tripla.

Para levar. Na DPOC, as exacerbações definem o grupo E independentemente dos sintomas; no grupo E, eosinófilos de 300/mm³ ou mais indicam começar já com LABA, LAMA e corticoide inalatório.

GOLD 2025/2026 Global Strategy for Prevention, Diagnosis and Management of COPD.

Revisa: UERJ recorrente: escolha do inalatório na DPOC pelos eosinófilos e pelas exacerbações (GOLD), cruzado com o padrão de rótulo verdadeiro